

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENFERMAGEM E SAÚDE COLETIVA

DANIELA GIOTTI DA SILVA

PRAZER, SOFRIMENTO E ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS DOS TRABALHADORES
DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NOS CUIDADOS PALIATIVOS NO CENÁRIO DA
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

PORTO ALEGRE

2026

DANIELA GIOTTI DA SILVA

PRAZER, SOFRIMENTO E ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS DOS TRABALHADORES
DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NOS CUIDADOS PALIATIVOS NO CENÁRIO DA
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem como requisito parcial para o
título de mestra.

Área de Concentração: Políticas e Práticas em Saúde e
Enfermagem

Linha de Pesquisa: Saúde Mental e Enfermagem

Orientadora: Prof^a Dr^a Maria de Lourdes Custódio Duarte

PORTO ALEGRE

2026

CIP - Catalogação na Publicação

da Silva, Daniela Giotti

Prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar nos cuidados paliativos no cenário da terapia intensiva pediátrica / Daniela Giotti da Silva. -- 2026.

109 f.

Orientadora: Maria de Lourdes Custódio Duarte.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Cuidados Paliativos. 2. Unidades de Terapia Intensiva. 3. Pediatria. 4. Equipe Multiprofissional. 5. Saúde do Trabalhador. I. Duarte, Maria de Lourdes Custódio, orient. II. Título.

Daniela Giotti da Silva

Prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar diante da criança em cuidados paliativos na terapia intensiva

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Enfermagem.

Aprovada em Porto Alegre, 23 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CUSTODIO DUARTE
Data: 28/04/2026 22:05:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Maria de Lourdes Custódio Duarte

Presidente da Banca – Orientadora

PPGENF/UFRGS

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVANA MARIA ZARTH
Data: 30/03/2026 21:57:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. Silvana Maria Zarth

Membro da banca

UFRGS

Documento assinado digitalmente
gov.br MARTA KOLHS
Data: 23/03/2026 13:48:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. Marta Kolhs

Membro da banca

UDESC/DENF

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO WAGNER CAMATTA
Data: 28/03/2026 10:33:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Marcio Wagner Camatta

Membro da banca

PPGENF/UFRGS

O verdadeiro perigo existe quando não há
mais desejo, quando ele não é mais possível.
Christophe Dejours

AGRADECIMENTOS

Agradeço a tudo que me trouxe até o final desta jornada, todos os dias e pensamentos que alicerçaram essa conquista e todas as pessoas que vibraram e vibram por mim!

Agradeço a Deus, que permitiu conquistar tudo o que almejei até agora, e ao longo de minha vida, e peço a Ele que me dê sabedoria para conquistar muito mais.

Agradeço meu pai e minha mãe por sempre estarem presentes e me apoiarem em todas as minhas escolhas e em toda a minha trajetória até aqui. Com a ajuda e parceria deles, com certeza, o caminho se tornou mais fácil. Para eles, dedico este estudo e todo o meu amor. Obrigada por tudo!

Agradeço à minha orientadora, Professora Doutora Malu, pelos ensinamentos e pela confiança depositada em mim nesses seis anos de parceria. Obrigada pela disponibilidade, compreensão e incentivo, foram fundamentais para a construção desta pesquisa, e da pesquisadora que sou.

Agradeço à bolsista de iniciação científica, Eduarda, que participou de pertinho e com impecável empenho para a construção dessa pesquisa, auxiliando na coleta, transcrição e produção de dados.

Ao meu companheiro, parceiro de vida e conquistas, Douglas, que esteve ao meu lado trabalhando de *home office* e acompanhou de pertinho a escrita da minha dissertação. Obrigada por me fazer melhor todos os dias. Te amo, amor.

Ao meu Club do Livro, composto pelas amigas Alessandra, Natália e Aline. Iniciei a trajetória do mestrado individualmente e hoje saio rodeada de pessoas que compartilham muitos objetivos e hobbies em comum: livros, viagens, café e vinhos! Esses momentos tornaram o mestrado mais fácil e menos fatigante.

Agradeço aos colegas do Serviço de Enfermagem Pediátrica (SEPED) e pelo Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica (SMIP) pelo acolhimento e parceria. Vocês foram essenciais para o desenvolvimento do meu estudo.

Aos meus colegas e chefia do Hospital da Criança Santo Antônio no qual atualmente compartilho as minhas tardes, por flexibilizarem minha rotina em prol das minhas atividades acadêmicas. Gratidão a todos!

Agradeço à minha banca examinadora, compostas pelas professoras Marta, Márcio e Silvana que acompanharam recortes da minha jornada enquanto mestranda. Obrigada por aceitaram dedicar seu tempo e conhecimento para avaliar meu trabalho, com certeza, será de grande valia para a qualificação dessa pesquisa.

Ao Grupo de Pesquisa, por ser potente e propor atividades para além de pesquisa, mas também debates e reflexões que faz pensar criticamente um cuidado pautado em respeito, empatia, dignidade e sensível.

Agradeço aos meus pacientinhos, que me ensinaram que força, garra e superação não tem idade. Aprendi muito com minhas criancinhas e suas famílias.

E por fim, mas não menos importante, agradeço à todas as pessoas que contribuíam direta ou indiretamente para o meu crescimento pessoal e profissional durante a minha jornada como mestranda em Enfermagem.

Meu muito obrigada!

RESUMO

SILVA, DG. **Prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar nos cuidados paliativos no cenário da terapia intensiva pediátrica.** 2026. 110p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2026.

Introdução: O processo decisório em cuidados paliativos pediátricos (CPP) ainda é uma temática atual que vem ganhando destaque no cenário das práticas assistenciais à criança com doença crônica, principalmente em decorrência das discussões éticas em torno dos avanços tecnológicos, que podem contribuir para o prolongamento do morrer. O presente estudo buscará responder à seguinte questão norteadora: “Quais os fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar nos cuidados paliativos no cenário da unidade de terapia intensiva pediátrica?”. **Objetivo:** Analisar os fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar no cuidado à criança em cuidados paliativos em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. **Método:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que foi realizada em uma unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP) de um hospital geral e universitário de referência do Sul do Brasil. Participaram 21 trabalhadores da equipe multidisciplinar que atenderam aos critérios de seleção do estudo. As informações foram coletadas através de observação participante e entrevista semiestruturada e analisadas conforme Análise Temática sob a ótica do referencial teórico da Psicodinâmica do Trabalho, de Christophe Dejours. O estudo recebeu parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição sob o nº sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição proponente com o nº 7.726.407. **Resultados:** A organização laboral dos trabalhadores da equipe multidisciplinar na unidade de terapia intensiva pediátrica abrangeu tanto a estrutura, englobando aspectos da ambiência, quanto do funcionamento da unidade, incluindo reuniões e *rounds* multidisciplinares. Em relação aos fatores de prazer no trabalho, a flexibilização de rotinas gerando promoção de conforto; o auxílio na elaboração do luto da família e despedida digna da criança; e, o reconhecimento do trabalhador e a importância do trabalho coletivo foram mencionados pelos trabalhadores como aspectos de satisfação. Em se tratando dos fatores de sofrimento, a indefinição sobre paliatividade e terminalidade, a inevitabilidade da terminalidade, a repercussão do ambiente laboral no espaço da vida pessoal, e sintomas psicossomáticos foram citados como fatores de sofrimento ao cuidar de crianças em cuidados paliativos. Já, as estratégias defensivas coletivas incluíram revisão de casos com os colegas e participação na ginástica laboral, e as individuais incluíram psicoterapia e atividades com pessoas afetivamente próximas, bem como o silenciamento de grupos institucionais como mecanismos de enfrentamento para amenizar a carga psíquica proveniente do trabalho. **Considerações Finais:** O estudo contribuiu com a visibilidade da dinâmica de unidades críticas, sendo possível auxiliar no fortalecimento de aspectos positivos no cuidado das crianças em cuidados paliativos. Ademais, o trabalho gera repercussão tanto na própria vida laboral como no espaço pessoal dos trabalhadores, e a utilização de estratégias são formas de controlar e diminuir a carga psíquica.

Descritores: Cuidados Paliativos; Unidades de Terapia Intensiva; Pediatria; Equipe Multiprofissional; Saúde do Trabalhador.

ABSTRACT

SILVA, DG. **Pleasure, suffering, and defensive strategies of multidisciplinary team workers in palliative care in the pediatric intensive care.** 2026. 110p. Dissertation (Master's in Nursing) – Postgraduate Program in Nursing, School of Nursing and Public Health, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2026.

Introduction: The decision-making process in pediatric palliative care (PPC) remains a current topic that has gained prominence in the context of care practices for children with chronic diseases, mainly due to ethical discussions surrounding technological advancements that may contribute to prolonging death. This study will seek to answer the following guiding question: "What are the factors of pleasure, suffering, and defensive strategies of multidisciplinary team workers in palliative care within the pediatric intensive care unit setting?". **Objective:** To analyze the factors of pleasure, suffering, and defensive strategies of multidisciplinary team workers in the care of children in palliative care in a Pediatric Intensive Care Unit. Method: This is a qualitative study, conducted in a pediatric intensive care unit (PICU) of a general and university reference hospital in Southern Brazil. Twenty-one multidisciplinary team workers who met the study's selection criteria participated. Data were collected through participant observation and semi-structured interviews and analyzed using Thematic Analysis from the perspective of Christophe Dejours' Psychodynamics of Work theoretical framework. The study received a favorable opinion from the institution's Research Ethics Committee under number [number missing in original text] and was approved by the Research Ethics Committee (CEP) of the proposing institution under number 7.726.407. **Results:** The work organization of the multidisciplinary team in the pediatric intensive care unit encompassed both the structure, including aspects of the environment, and the functioning of the unit, including multidisciplinary meetings and rounds. Regarding factors of job satisfaction, the flexibility of routines promoting comfort; assistance in processing family grief and a dignified farewell for the child; and worker recognition and the importance of collective work were mentioned by the workers as aspects of satisfaction. Concerning factors of suffering, the uncertainty surrounding palliative and terminal care, the inevitability of terminal illness, the impact of the work environment on personal life, and psychosomatic symptoms were cited as factors of suffering when caring for children in palliative care. Collective coping strategies included case review with colleagues and participation in workplace gymnastics, while individual strategies included psychotherapy and activities with close people, as well as silencing institutional groups as coping mechanisms to alleviate the psychological burden of the work. **Final Considerations:** This study contributed to the visibility of the dynamics of critical care units, making it possible to assist in strengthening positive aspects in the care of children in palliative care. Furthermore, the work generates repercussions both in the work life itself and in the personal space of the workers, and the use of strategies are ways to control and reduce the psychological burden.

Descriptors: Palliative Care; Intensive Care Units, Pediatric; Intensive Care Units, Neonatal; Nursing, Team; Occupational Health.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIDS	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
ANCP	Academia Nacional de Cuidados Paliativos
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CFM	Conselho Federal de Medicina
CNS	Conselho Nacional de Saúde
COFEN	Conselho Federal de Enfermagem
COFFITO	Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
COMPESQ	Comissão de Pesquisa
COREQ	<i>COnsolidated Criteria for REporting Qualitative research</i>
CP	Cuidado Paliativo
CPP	Cuidados Paliativos Pediátricos
GEPESM	Grupo de Estudo e Pesquisa em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental
GISO	Grupo Interdisciplinar de Saúde Ocupacional
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
INCA	Instituto Nacional do Câncer
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MEC	Ministério da Educação
OMS	Organização Mundial de Saúde
PDT	Psicodinâmica do Trabalho
RCP	Ressuscitação cardiopulmonar
SAV	Suporte Avançado de Vida
SBCP	Sociedade Brasileira de Cuidados Paliativos
SBED	Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor
SEPED	Serviço de Enfermagem Pediátrica
SMIP	Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica
SUS	Sistema Único de Saúde
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TCR	Trabalho de Conclusão de Residência
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
UTIP	Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul

LISTA DE FIGURAS

Quadro 1 – Grupo de pacientes que podem se beneficiar de cuidados paliativos pediátricos.....	28
Quadro 2 – Perfil dos participantes do estudo.....	47
Quadro 3 – Categorias e unidades de registro do estudo.....	48

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	18
2	OBJETIVOS.....	22
2.1	Objetivo geral.....	22
2.2	Objetivos específicos.....	22
3	REVISÃO DA LITERATURA.....	23
3.1	O contexto histórico dos Cuidados Paliativos.....	23
3.2	Criança em cuidados paliativos no contexto de unidades críticas.....	27
4.	REFERENCIAL TEÓRICO.....	35
4.1	Psicodinâmica do Trabalho.....	35
5	METODOLOGIA.....	41
5.1	Tipo de estudo.....	41
5.2	Delimitação do estudo.....	41
5.2.1	Local do estudo.....	41
5.2.2	Participantes do estudo.....	42
5.2.2.1	Critérios de inclusão.....	42
5.2.2.2	Critérios de exclusão.....	42
5.3	Coleta das informações.....	43
5.3.1	Observação participante.....	43
5.3.2	Entrevistas semiestruturadas.....	44
5.4	Análise das informações.....	44
5.5	Aspectos éticos.....	45
6	RESULTADOS.....	47
	Artigo 1 – Organização do trabalho e o prazer dos trabalhadores no contexto da criança em cuidados paliativos.....	50
	Fatores de sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores no cuidado paliativo pediátrico na terapia intensiva.....	68
	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	91
	REFERÊNCIAS.....	94
	APÊNDICE A – Roteiro de Observação.....	100
	APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista.....	101
	ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	102

ANEXO B – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.....	104
---	------------

PRE(ÂMBULO): É preciso saber viver¹

O termo “(pre)âmbulo” significa a primeira etapa da escrita. A palavra “âmbulo” vem do latim (*ambulum*) e quer dizer “passeio”, e é nada mais do que uma trilha de onde queremos chegar. Ou seja, antes de finalmente decidir pesquisar “Cuidados paliativos dos trabalhadores da equipe multidisciplinar sob a ótica da Psicodinâmica do Trabalho (PDT)”, há uma trajetória repleta de “porquês”, que foi se moldando até chegar na profissional e pessoa que aqui vos fala.

A escolha por temáticas de cunho científico ocorre a partir de inquietações pessoais do pesquisador. Dessa maneira, nesse primeiro momento, intenciono realizar uma apresentação daquilo que me impulsiona a construir esse lugar de reflexão e diálogo. Cotidianamente, aprendemos e ensinamos nossos conhecimentos aos outros, construimo-nos, reconstruimo-nos, e nos (re)fazemos enquanto sujeitos, edificando nosso percurso profissional.

A título de contextualização, é importante ressaltar que observar o processo de organização do trabalho e as repercussões na vida profissional (e até na vida pessoal) do trabalhador, sabendo que isso pode impactar diretamente no cuidado para com os seus pacientes, é um tema que tem meu interesse desde a graduação em enfermagem.

Um trabalhador saudável mentalmente, profissionalmente satisfeito e com ambições que vão ao encontro dos recursos e apoio da organização é um trabalhador que, em sua maioria, vai oferecer um cuidado qualificado, proporcionando bem-estar àqueles a sua volta. Entretanto, quando a alta carga psíquica se sobressai aos momentos de prazer, ou quando suas estratégias de enfrentamento são falhas, o profissional tende a adoecer psiquicamente, impactando diretamente na assistência ao paciente.

Na metade da faculdade, tive oportunidade de ingressar no Grupo Interdisciplinar de Saúde Ocupacional (GISO), onde através do grupo de pesquisa, pude experienciar e agregar conhecimentos em coleta de dados em uma pesquisa que avaliou a qualidade de vida, uso de medicamentos e qualidade de sono de residentes multiprofissionais.

Estar nessa pesquisa me impulsionou a pensar mais sobre essa abordagem e olhar para o trabalhador, pois aquele que cuida também precisa ser cuidado, precisamos estar bem para cuidar dos nossos pacientes. Sempre tive um perfil de aluna que buscava atividades para além das disciplinas obrigatórias do currículo, dessa maneira, um semestre depois, no 6º período da faculdade, tive a oportunidade de ser monitora da disciplina de Cuidados de enfermagem em

¹É preciso saber viver (Titãs/Roberto Carlos)

Saúde Mental I, que é ofertada no 3º semestre da graduação. A monitoria oportuniza o graduando, tanto a observar aspectos relacionados à docência, quanto a transmitir seu conhecimento de forma horizontal, com os alunos de semestres anteriores, explorando principalmente as habilidades de comunicação no ensino.

Com a monitoria, meu contato com a saúde mental ficou mais próximo e, então, ingressei para o Grupo de Estudo e Pesquisa em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental (GEPESM), o qual frequento até os dias atuais, enquanto mestranda. Meu primeiro contato com a PDT foi ainda na iniciação científica, e através da leitura de capítulos dos livros de Christophe Dejours, pude contribuir em uma pesquisa realizada em uma unidade de internação oncopediátrica, que utilizou esse referencial.

Ademais, meu anseio, neste momento da graduação era desenvolver habilidades técnicas para além do campo teórico, por isso, conciliei meus horários para realizar estágio não-obrigatório, que foi na pediatria. E foi neste cenário, estando à beira-leito rotineiramente, que me surgiu as primeiras inquietações associada à assistência (a cabeça da bolsista de iniciação científica borbilhava ideias): percebi que haviam dois leitos destinados a crianças com transtornos mentais em meio a uma unidade de cuidados pediátricos gerais, e o cuidado, majoritariamente, era generalizado, pois os enfermeiros possuíam pouca expertise para cuidar de criança com especificidades relacionadas a saúde mental, sendo assim, o olhar para as questões clínicas era mais apurado.

Essa inquietude se tornou meu problema de pesquisa e meu trabalho de conclusão de curso (TCC) se propôs a analisar esse cuidado, que por sua vez, evidenciou que o cenário mais apropriado para essas crianças era uma unidade específica para psiquiatria infantil pois havia muita dificuldade de manejo por parte desses enfermeiros, já que não possuíam especialização e tampouco habilidades específicas para lidar com casos de crises psíquicas.

Após a graduação, meu desejo era ter mais experiência prática, antes de ingressar na carreira docente, além de observar alguns “nós” na *práxis* do enfermeiro que partissem de um olhar de dentro do contexto laboral, para projetar pesquisas que pudessem agregar em evidências para melhoria da assistência. Sendo assim, a longa e agradável trajetória com minha orientadora, desde a iniciação científica até os dias atuais, me proporciona liberdade de unir duas grandes áreas que tenho apreço: saúde mental e pediatria.

Nesse sentido, realizei residência com ênfase em Saúde da Criança em um hospital do município de Porto Alegre, e para o trabalho de conclusão da residência (TCR), me aprofundei nos estudos utilizando o referencial de Dejours, no qual analisei aspectos relacionados ao prazer e sofrimento de enfermeiros envolvidos no cuidado de crianças em processo de

institucionalização. Neste estudo, evidenciei que a dedicação para a melhora do estado de saúde gera satisfação profissional, entretanto, aspectos que ultrapassam a barreira profissional-pessoal, logo após o término do horário de trabalho geram sofrimento no cotidiano laboral.

Complementarmente, durante a residência, dentre os vários campos nos quais transitei, o que mais me interessou foi a unidade terapia intensiva pediátrica. Esse cenário foi um dos que mais me mobilizou devido à alta sobrecarga dispendida e alto poder de resiliência para trabalhar com casos graves e delicados, que muitas vezes envolviam dilemas éticos e eram necessárias discussões com a equipe de bioética. Trabalhar em cenários críticos de cuidado é conviver diariamente em cenário de tensão, de tecnologias duras em saúde, e, infelizmente, contextos onde nem a tecnologia mais atual pode impedir o curso de morte de uma doença.

A morte passou a fazer parte da minha rotina assistencial, inevitavelmente, e com ela os infinitos tabus e conceitos advindos de cada profissional e família. E, muitas vezes, esse processo irreversível vem acompanhado de diversos sentimentos por parte da família, e não raro, impacta de diferentes formas nos trabalhadores, pois estar diante da morte de uma criança rompe com todo o preceito natural da infância.

Ao acompanhar os pais nesse processo de assimilação do diagnóstico e emocional da perda de seus filhos, os trabalhadores mobilizam muitos sentimentos que, por vezes, podem ser expressos de várias maneiras em suas atitudes: absenteísmos e afastamentos; desorganização emocional; repressão e exacerbação de sentimentos, o que pode impactar negativamente na sua saúde mental e qualidade do cuidado ofertado, sucessivamente.

Nesse sentido, a motivação para realizar essa pesquisa surgiu a partir da percepção da minha prática assistencial, onde no cenário crítico de cuidado, com dispositivos de alta tecnologia, há uma expectativa dos familiares e, sobretudo, da equipe assistencial baseada na mudança do curso da doença diante da possibilidade de cura. Assim, o déficit de conhecimento, sobretudo divergente sobre o tema dos cuidados paliativos, pode criar um estigma dentro das unidades de terapia intensiva, expondo que a abordagem paliativa é sinônimo de falha no papel de promoção da saúde desenvolvido pelos profissionais.

Ademais, muitas lacunas ainda permanecem pendentes em relação à adoção de medidas paliativas às crianças hospitalizadas em unidades críticas, acredito que muitas delas têm relação com diferenças na compreensão de conceitos relativos ao cuidado paliativo e falhas em processos de comunicação, seja entre os membros da equipe multidisciplinar bem como entre equipe e família.

Na mesma lógica, percebo que outro impasse pode ser encontrado na dificuldade de se obter um consenso por parte de toda a equipe a respeito das possibilidades terapêuticas e

irreversibilidade do agravamento de saúde da criança. Esse consenso faz parte de um processo complexo, gerador de ansiedade tanto na equipe quanto família, e, que pode levar tempo para se concretizar, contribuindo mais uma vez, para o estabelecimento desses cuidados de forma tardia, quando o paciente já está em fase de terminalidade, por exemplo.

Por fim, cabe ressaltar que defrontar com esses potenciais fatores de sofrimento do trabalhador diante desse momento não é um processo fácil, mas repleto de significados. É nesse momento que emerge a possibilidade de uma intensa apropriação de sentido e provocação à ressignificação desses sentimentos, sejam com estratégias de enfrentamento individuais, bem como coletivas, contando com o apoio da instituição.

1. INTRODUÇÃO

Em um panorama geral, a saúde infantil vem apresentando melhora significativa nos últimos anos, pois o Brasil vem conquistando diminuição nas taxas de mortalidade infantil. A partir dessas mudanças, somadas ao contexto da transição epidemiológica, surgiram novas demandas para o sistema de saúde, necessitando assistir às crianças que apresentam condições crônicas de saúde com uma gama de etiologias e prevalências distintas (Migoto; Saganski; Peres; Freire *et al.*, 2021).

Além disso, muitas dessas crianças possuem um histórico de saúde associado a várias comorbidades concomitantemente. Embora os avanços das técnicas da medicina estejam trazendo indiscutíveis vantagens para a sociedade, muitas vezes acarretam em consequências negativas, paradoxais e indesejáveis, tais como o suposto prolongamento da vida nas unidades críticas^a a todo custo, nas quais o desejo de evitar a morte culmina com o prolongamento da vida (distanásia) e altos custos, tanto emotivos quanto econômicos (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

A distanásia, extensão exagerada do processo da morte, é a manutenção artificial da vida, e na grande maioria dos casos ocorre no cenário de terapia intensiva, quando se excede os limites técnicos e deontológicos e submete-se a criança a procedimentos dolorosos e fúteis, para que sobrevivam às custas de sofrimento desnecessários de todos que a acompanham (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021), contribuindo para uma vida sem qualidade e sem dignidade.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (World Health Organization, 2017), cuidado paliativo (CP) é uma abordagem que objetiva promover qualidade de vida a pacientes e familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, buscando alívio e prevenção de sofrimento, e envolvendo para além do tratamento da dor física, o cuidado com questões de ordem psicológica, social e espiritual.

Assim, o CP não se baseia em protocolos, mas sim em princípios, indicando-se o cuidado desde o diagnóstico e expandindo o campo de atuação e de cuidado para a criança e sua família,

a. Unidades críticas são aquelas que oferecem cuidados de terapia intensiva e o uso de dispositivos invasivos e muitas vezes se tratam de ambientes que implicam em exigências em todos os aspectos, sejam eles físico (desgaste no atendimento), mental (estado de alerta permanente), e espiritual (convívio continuado com o sofrimento, com a dor e com a morte).

inclusive no período de luto. Dessa maneira, não se utiliza mais o termo “impossibilidade de cura”, mas sim, a possibilidade ou não de tratamento modificador da doença, afastando a ideia de “não ter mais nada a fazer” (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

Até pouco tempo atrás se entendia que o emprego de medidas paliativas somente era considerado nos momentos que antecediam a morte, de modo que o tratamento curativo e os CP situavam-se em polos opostos e excludentes. Dessa forma, o conhecimento aprofundado do histórico de atendimento de crianças com dependência tecnológica e com doenças debilitantes e progressivas, assim como nos casos agudos, mas refratários à terapêutica, é fundamental para a melhor tomada de decisão na determinação dos Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) (Nieto; Seidl, 2023).

Assim, os CPP recorrem à multidimensionalidade do sujeito, através do desempenho de diferentes trabalhadores da saúde, que unem conhecimento clínico de suas respectivas áreas, para o cuidado das crianças e suas famílias. A equipe deve possuir habilidades a fim de auxiliar a adaptação nas mudanças de vida impostas pela doença, transcendendo o cuidar e o atendimento das dimensões e necessidades individuais, a partir da construção de vínculo (Silvestri; Santos; Belini *et al.*, 2021).

Muitos profissionais da área de CPP têm incorporado aspectos positivos do cuidado em seu trabalho, incluindo o foco na construção de significados às crianças e famílias, como uma estratégia terapêutica (Kluger; Arnold, 2023). Por essa razão, o ambiente do trabalho, somado às peculiaridades dos CPP, é caracterizado por uma ambivalência constante, e pode proporcionar tanto experiências gratificantes, quanto desafiadoras (Bottini; Paiva; Gomes, 2021).

Os desafios da equipe multidisciplinar no contexto dessas unidades críticas ocorrem por meio de barreiras, como a falta de um diálogo convergente entre a própria equipe de saúde e a falta de preparo para lidar com essas situações, que se mostram como entraves que se refletem nas relações do cuidado (Silva; Silva; Silva *et al.*, 2021).

Nesse sentido, algumas situações que ocasionam sofrimento aos trabalhadores acontecem quando há falha na intermediação entre as expectativas do trabalhador e a realidade imposta pela organização e gerência do trabalho. A frustração e o sentimento de impotência perante a não evolução da clínica do paciente são situações geradoras de sofrimento (Dejours, 2011), muitas vezes, por não compreenderem com clareza algumas condutas definidas.

Nessa lógica, a Psicodinâmica do Trabalho (PDT) privilegia a clínica como modo de construção do conhecimento, de interpretação e de análise do trabalho, colocando-se como

instrumento capaz de compreender tanto os processos de saúde quanto as patologias do trabalho (Dejours, 2012).

A PDT preocupa-se com as relações do sujeito no coletivo, partindo de um duplo enfoque: dos procedimentos defensivos contra o sofrimento no trabalho e do sujeito à história atual e pública no trabalho. Ela busca identificar as relações entre os trabalhadores, vivências de sofrimento e de prazer e como o trabalho se organiza, entendendo o papel da subjetividade e das estratégias defensivas construídas pelos próprios trabalhadores no local onde atuam (Dejours, 2018). Para a PDT, o trabalho é entendido como categoria ontológica, com potencial de ser fonte de prazer ou de sofrimento.

Dito isso, vale ressaltar que o processo decisório em cuidados paliativos pediátricos (CPP) ainda é uma temática atual que vem ganhando destaque no cenário das práticas assistenciais à criança com doença crônica, principalmente em decorrência das discussões éticas em torno dos avanços tecnológicos, que podem contribuir para o prolongamento do morrer, deixando os pacientes e seus familiares carentes desse tipo de assistência, quando necessário. Dessa maneira, encontram-se muitos estudos bem sustentados e estruturados no que se refere à área da oncologia pediátrica (Snaman; McCarthy; Wiener L *et al.*, 2020. Duarte; Glanzner; Bagatini *et al.*, 2021. Popa; Mîndru; Dumitrache *et al.*, 2024), entretanto, há uma lacuna no conhecimento, de estudos que abordem CP em áreas de terapia intensiva, em detrimento de doenças não somente oncológicas. Dessa maneira, foram encontrados estudos sobre cuidados paliativos pediátricos (Manzan; Ferreira; Resende *et al.*, 2025. Zernikow, 2024. Santos; Moreira; Sevilha, 2023. Kluger; Arnold, 2023. Schäfer, Silva, 2024), o trabalho em terapia intensiva pediátrica (Cardoso; Oliveira; Souza, *et al.*, 2022. Pizzol; Salbego; Salcher *et al.*, 2024), organização do trabalho e a PDT (Dejours, 2018. Dejours; Abdoucheli; Jayet, 2011. Dejours, 2022. Oliveira; Centenaro; Garcia *et al.*, 2022. Guariento; Montezeli; Gastaldi *et al.*, 2024). Entretanto, há uma lacuna no conhecimento de estudos que abordem CPP em áreas de terapia intensiva, relacionando a organização do trabalho e fatores geradores de prazer e sofrimento sob a ótica da PDT.

Corroborando com isso, as dificuldades para a implementação das ações dos CPP se assemelham a nível internacional. Alguns países como os Estados Unidos (EUA), Reino Unido, Canadá e Austrália apresentaram demandas voltada para a capacitação dos profissionais que lidam diretamente na assistência, para identificar quando o encaminhamento para CPP é indicado para uma criança (Silva; Silva; Silva *et al.*, 2021).

Assim, esse estudo justifica-se, pois entende-se a importância de realizar pesquisas que investiguem os fatores que geram prazer, sofrimento e as estratégias defensivas dos

trabalhadores da equipe multidisciplinar nos cuidados paliativos no cenário da terapia intensiva pediátrica à luz da PDT.

A partir dessas considerações, o presente estudo buscará responder à seguinte questão norteadora: “Quais os fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar nos cuidados paliativos no cenário da unidade de terapia intensiva pediátrica?”.

O mencionado até aqui permite o seguinte pressuposto: a carga psíquica dispendida no cuidado da criança em CP é elevada, sobretudo em cenário de altas tensões, como da terapia intensiva. Nesse sentido, o cuidado à criança em medidas paliativa pode ser influenciado pelas condições laborais, ou seja, o trabalho pode repercutir diretamente na vida e na qualidade da assistência ofertada pelos trabalhadores da equipe que atuam nesses setores.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar os fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar nos cuidados paliativos no cenário da unidade de terapia intensiva pediátrica.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar os fatores de prazer dos trabalhadores da equipe multidisciplinar decorrentes do cuidado paliativo prestado em UTI Pediátrica;
- Identificar os fatores de sofrimento dos trabalhadores da equipe multidisciplinar decorrentes do cuidado paliativo prestado em UTI Pediátrica;
- Conhecer as estratégias defensivas individuais e coletivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar diante do cuidado paliativo no contexto da UTI Pediátrica.

3 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura versará sobre O contexto histórico dos Cuidados Paliativos e Criança em cuidados paliativos no contexto de unidades críticas.

3.1 O contexto histórico dos Cuidados Paliativos

Os CP surgem do movimento *hospice*, originado por Cicely Saunders, na Inglaterra, que teve suas primeiras experiências com pacientes gravemente enfermos, despertando seu interesse em aliviar a dor e outros sintomas que acometiam os pacientes no final da vida. Além de enfermeira, assistente social e escritora, Saunders tornou-se médica aos 40 anos de idade, também estudou filosofia, política e economia, sendo que seus artigos foram fundamentais para impulsionar o movimento, referentes aos cuidados dispensados no final da vida (Silva, 2015).

Ela disseminou um novo olhar sobre o cuidar de pessoas em fases avançadas de algumas doenças, com dois focos principais: o controle efetivo da dor e o cuidado para além da dimensão física, acolhendo as dimensões psicológicas, sociais e espirituais de pacientes e familiares (Silva, 2015).

O termo *hospice* tem sua origem na palavra *hospes*, que significa estrangeiro ou estranho, e no termo *hospitalis*, que significa hospitalidade e alojamento. Na Idade Média, estes *hospices* tinham como objetivo acolher os peregrinos e doentes de modo que pudessem descansar e se recuperar para seguirem em sua jornada ou abrigar aqueles que se apresentavam muito debilitados (Silva, 2015).

Já na Idade Contemporânea, os *hospices* destinavam-se a acolher e cuidar de pessoas com doenças incuráveis, em estágio avançado e com diagnóstico de curto tempo de vida, concepção esta que permeia a compreensão sobre o tema até os dias atuais (Silva, 2015).

É importante salientar que tais cuidados realizados no contexto dos primeiros *hospices* era uma prática comum nas primeiras civilizações, uma vez que sem desenvolvimento das ciências da saúde, a atenção prestada às pessoas doentes restringia-se à tentativa de controle de sintomas e rituais para o conforto espiritual. A cura física, muitas vezes, era impossível devido aos limites científicos, sendo o objetivo principal cuidar da pessoa em todo o percurso da doença e também em sua morte (Silva, 2015).

A primeira instituição a utilizar o termo *hospice* para uma de suas alas foi o *St. Vincent Hospital*, em 1830, da Congregação de São Vicente de Paulo, em Sidnei, na Austrália. Entretanto, na Grã-Bretanha a primeira instituição a denominar-se *hospice* foi o *Our Lady's Hospice for the Dying*, fundado em Dublin em 1879 pelas Irmãs de Caridade Irlandesas, e,

depois dele, muitos outros surgiram na Inglaterra no final do século XIX, dentre eles o *St. Lukes House* (Londres, 1893) e o *St. Joseph's Hospice for the Dying* (Londres, 1905), criado para acolher pessoas em fase terminal de tuberculose (Silva, 2015).

Na década de 60, a falta de preparo para o cuidado com a morte e a desumanização da saúde levaram a movimentos sociais em prol da promoção da dignidade no processo de morrer. O surgimento do Movimento Hospice Moderno, atualmente conhecido como Cuidado Paliativo foi através da iniciativa de Cicely Saunders (Silva, 2015).

De acordo com Saunders, as pessoas que estavam morrendo precisavam de dignidade, compaixão e respeito. Assim, criou o conceito de “dor total”, que é definida como a dor que envolve diferentes dimensões além da sua expressão física. Desta forma, a dor emocional, espiritual e a social também deveriam ser consideradas em uma perspectiva de cuidado integral (Silva, 2015).

Dessa maneira, um grande marco foi a fundação do primeiro *hospice* moderno, em 1967, chamado de *St. Christopher's Hospice*, onde estabeleceu a disciplina e a cultura dos CP, além de introduzir proposta para manejo mais eficaz da dor, acolhendo integralmente pacientes e familiares e desenvolvendo ensino e pesquisa direcionado a profissionais de vários países (Silva, 2015).

Além de Saunders, Elisabeth Kübler-Ross, médica psiquiatra suíça, trabalhou por décadas com pacientes portadores de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), câncer e demências, e desenvolveu um modelo compreensivo sobre as reações psicossociais desses pacientes frente ao diagnóstico da doença e à própria morte, conhecido mundialmente como Modelo Kübler-Ross, para compreensão sobre os sentimentos e pensamentos das pessoas que estavam vivenciando o processo de morrer (Silva, 2015).

Em 1982, a filosofia do Movimento Hospice Moderno chegou à OMS, que criou um grupo de trabalho, através do Comitê de Câncer, para definir políticas que viabilizassem o alívio da dor e que tivessem condutas semelhantes àsquelas prestadas no *hospice* para pacientes portadores de câncer e que pudessem ser recomendadas a outros países (Silva, 2015).

Para o universo pediátrico, o primeiro *hospice* infantil surgiu na Inglaterra somente em 1982, denominado *Helen House*. E em 1985, uma unidade pediátrica do *St. Mary's Hospital*, em Nova York (EUA), inaugurou um Serviço de Cuidados Paliativos Pediátrico (Lopes, 2023).

Em 1986, a OMS adotou pela primeira vez o termo ‘cuidados paliativos’ em função da dificuldade em traduzir o termo *hospice* para os diferentes idiomas, definindo-o como um cuidado para aqueles cuja doença não é responsiva a tratamentos curativos. Nesta ocasião,

reforçou a prioridade do controle da dor, de outros sintomas e da atenção aos problemas psicossociais, em especial aos pacientes em final de vida (Silva, 2015).

Em 1990, a OMS define os CP, sendo um marco na legitimação dessa prática no mundo, definindo-o como

“Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do Cuidado Paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e familiares” (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021, p.25).

Esta definição foi revisada em 2002 e substituída pela atual, no ano de 2017, tendo como principal mudança a inclusão de crianças nesse processo de cuidados: “Os cuidados paliativos são uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes (adultos e crianças) e suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia o sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas, sejam físicos, psicossociais ou espirituais” (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

O termo paliativo vem do latim “*pallium*”, e significa manto, cobertor, denotando que a doença enfrentada pelo paciente pode ser “coberta” por outros tratamentos para amenizar os sofrimentos decorrentes dela. Outra raiz de paliativo vem da palavra *palliare*, que significa amparar, proteger, cobrir, remetendo-nos à essência do cuidar, que não se restringe à cura física, mas configura um amplo espectro de ausculta da alma do paciente, que demanda necessariamente uma assistência holística para abarcar outras dimensões humanas: física, psicológica, social e espiritual (Silva, 2015).

O CP no Brasil teve seu início na década de 1980 e conheceu um crescimento significativo a partir do ano 2000, com a consolidação dos serviços já existentes (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021). O pioneirismo veio de Porto Alegre (RS), com a Professora Dra. Miriam Marteleite, anestesiológica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que em 1979 fundou o Serviço de Dor no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), e em 1983, o Serviço de Cuidados Paliativos. Em seguida, na cidade de São Paulo (SP), o médico fisiatra Dr. Antônio Carlos Camargo de Andrade Filho fundou o Serviço de Dor da Santa Casa em 1983, e em 1986, o de Cuidado Paliativo (Silva; Massi, 2022).

Na década de 80, a OMS emitiu um alerta sobre a falta de ações para o alívio do sofrimento físico e de suporte psicológico e social que sofriam os pacientes com câncer em condições muito avançadas. Foi, então, criado pela OMS o “*Expert Committee*” que abrangia médicos oncologistas de diversos países, entre eles, brasileiros (Silva; Massi, 2022).

A partir daí, foram implantados os primeiros serviços especializados em cuidados paliativos em diversos hospitais no Brasil, como o Centro de Suporte Terapêutico Oncológico pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 1996 no Rio de Janeiro (RJ), o qual foi transformado em Unidade de Cuidados Paliativos, e o Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, na modalidade de atendimento domiciliar, nos anos 2000 (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2015).

Paralelamente ao curso de expansão quantitativa e territorial dos serviços no país, surgiram também movimentos para a criação de entidades cujo propósito central foi o aprofundamento das discussões em torno das práticas paliativas em desenvolvimento, além da necessidade de integração dos serviços e luta pela ampliação do acesso aos serviços por parte da população com doenças graves. Nesse sentido, foram formadas a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), em 1982, a Sociedade Brasileira de Cuidados Paliativos (SBCP), em 1997, e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), em 2005 (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2015).

Em 2006, o Conselho Federal de Medicina (CFM), através da resolução nº 1.805/06, autorizou a prática dos CP no Brasil e, em 2009, incluiu no seu Código de Ética Médica a prática como princípio fundamental. Dessa maneira, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) também incorporaram, ambos em 2013, os CP em suas diretrizes (Silva; Massi, 2022).

Em 2018, a ANCP realizou um levantamento acerca dos serviços existentes no país e identificou uma linha do tempo na qual ficou evidenciada uma trajetória de desenvolvimento dos serviços a partir dos anos 90. Assim, pode ser verificado que até 1999, sete serviços iniciaram atividades no Brasil, e que o período entre 2011 e 2015 foi aquele no qual ocorreu maior expansão, com a criação de quarenta e nove deles (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2018).

De acordo com Atlas de Cuidados Paliativos (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2023), do total de 234 serviços, 123 pertencem ao Sistema Único de Saúde (SUS), 75 são privados e 36 prestam atendimento tanto SUS quanto privado. Em comparação com os dados de 2019, houve um aumento de 28% da oferta dos serviços no SUS, passando de 96 para 123, o que significa uma média de um serviço para cada 1,6 milhão de habitantes na rede pública. Como referência, a Associação Europeia de Cuidados Paliativos recomenda dois serviços especializados a cada 100.000 habitantes, nas três modalidades de atendimento: interconsulta, ambulatorial e domiciliar.

Ainda de acordo com o Atlas de Cuidados Paliativos, a média continental é de apenas 0,33 serviço por 100 mil habitantes, muito abaixo da referência internacional de 2 por 100 mil. Além disso, apenas Chile, Costa Rica, Estados Unidos e Uruguai atingem ou superam esse parâmetro. Outro indicador alarmante é a formação profissional: em 20 dos 35 países, os estudantes de medicina ainda não recebem treinamento obrigatório em cuidados paliativos, o que limita o crescimento de equipes qualificadas para atender à demanda crescente.

Portanto, ao longo do tempo houve melhoras na qualidade dos serviços, mas a assistência ainda carece de uma abordagem que preconize a construção de um planejamento de cuidados em conjunto com o paciente e familiares, o qual se baseia nos valores e preferências sobre as condições de vida atual ou em situação de saúde previsível, considerando os benefícios esperados dos tratamentos de suporte de vida. Dessa maneira, priorizar a tomada de decisão compartilhada, possibilita-se um cuidado centrado no paciente e sua família, promovendo maior autonomia e qualidade de vida.

3.2 Criança em cuidados paliativos no contexto de unidades críticas

Etimologicamente, a palavra “crônico” vem do grego *khronikós*, e significa “algo que dura muito tempo”. Assim, as condições crônicas são definidas como um conjunto de problemas de saúde persistentes, podendo durar vários anos ou décadas, que necessitam de cuidados contínuos e permanentes, como é o caso das condições não transmissíveis, condições transmissíveis persistentes, distúrbios mentais de longo prazo e deficiências físicas/estruturais contínuas (Rosa; Kobayashi; Paschuetto *et al.*, 2022).

A vivência da internação hospitalar para crianças que comumente é associada a experiências negativas e fatores estressores é algo ainda mais frequente ao longo da vida de crianças portadoras de condições crônicas, ocorrendo muitas vezes, de forma prolongada (Rosa; Kobayashi; Paschuetto *et al.*, 2022).

O número de pacientes pediátricos com essas condições tem aumentado a cada ano e, consequentemente, o número daqueles que se encontram na perspectiva de CP. De acordo com *Global Atlas of Palliative Care* (World Palliative Care Alliance, 2020), em todo mundo, estima-se que mais de 56,8 milhões de pessoas necessitam de CP todos os anos, a maioria (67,1%) são adultos com mais de 50 anos e pelo menos 7% são crianças.

Dessa maneira, o desenvolvimento tecnológico pode contribuir para a redução da mortalidade infantil, ao passo que também pode provocar um aumento das taxas de sobrevivência das crianças com patologias graves e potencialmente letais, que necessitam de CP complexos (Lopes, 2023). Assim, apesar do crescente reconhecimento da importância da

assistência às crianças, os CPP ainda apresentam um desenvolvimento mais lento, quando comparado aos adultos.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (2021), seis grandes grupos de pacientes se beneficiariam de CPP, conforme a tabela abaixo.

Quadro 1 – Grupo de pacientes que podem se beneficiar de cuidados paliativos pediátricos

Grupos	Situações envolvidas	Exemplos de doenças e condições
Grupo 1	Crianças com condições agudas de risco de vida, das quais a recuperação pode ou não possível	Qualquer doença ou lesão críticas desnutrição grave
Grupo 2	Crianças com condições crônicas de risco de vida que podem ser curadas ou controladas por um longo período, mas que também podem morrer	Malignidades, tuberculose multirresistente, HIV/AIDS
Grupo 3	Crianças com condições progressivas de risco de vida para as quais não há tratamento curativo disponível	Atrofia Muscular Espinhal, Distrofia Muscular de Duchenne
Grupo 4	Crianças com condições neurológicas graves que não são progressivas, mas podem causar deterioração e morte	Encefalopatia estática, tetraplegia espástica, espinha bífida
Grupo 5	Recém-nascidos que são gravemente prematuros ou têm anomalias congênicas graves	Prematuridade grave, anencefalia, hérnia diafragmática congênita, trissomia do 13 ou do 18
Grupo 6	Membros da família de um feto ou criança que morre inesperadamente	Morte fetal, encefalopatia hipóxico-isquêmica, sepse avassaladora em criança previamente saudável, trauma por acidente de veículo motorizado, queimaduras, etc.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021

No período infanto-juvenil, os CP abrangem muitas doenças, com evoluções bastante diferenciadas. Mundialmente, crianças com HIV/AIDS e malformações congênicas representam quase 46% da necessidade de CP, seguidos por crianças com prematuridade extrema e trauma de parto (quase 18%) (World Palliative Care Alliance, 2020). No Brasil, as doenças congênicas e genéticas são mais prevalentes, seguidas de condições neurológicas crônicas e onco-hematológicas (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021).

Importante destacar que, em muitas dessas patologias, as crianças precisam ser acompanhadas por longos períodos, podendo chegar a vida adulta com uma trajetória marcada por um processo de cuidado continuado, com internações prolongadas e realização de muitos procedimentos. Em outros, o contato da equipe de unidade de terapia intensiva (UTI) se dá

apenas perto ou no momento do óbito, mostrando também o caráter agudo do cuidado (Lopes, 2023).

Complementarmente, pacientes com estes perfis epidemiológicos apresentam índices elevados de admissões em UTI, sendo imprescindível a necessidade de instituir medidas que melhorem a qualidade de vida, livre de tratamentos que prolonguem o sofrimento. Não obstante, o modelo assistencial adotado nas UTIs é geralmente pautado em princípios biomédicos, curativistas e com densidade tecnológica que nem sempre permitem um cuidado centrado nas necessidades humanas básicas, no incentivo ao autocuidado e na autonomia do sujeito (Martins; Oliveira; Silva *et al.*, 2022).

No entanto, para que esses cuidados sejam ofertados de forma adequada, é necessário que sejam promovidos por uma equipe multiprofissional, por meio de uma abordagem integral. Assim, é possível proporcionar a prevenção e a identificação precoce do sofrimento em todos os campos que afetam a dignidade humana (Martins; Oliveira; Silva *et al.*, 2022. World Palliative Care Alliance, 2020).

Todavia, grande parte dos profissionais da saúde e gestores ainda associam os CP a uma assistência voltada somente para pacientes com neoplasias e em terminalidade de vida, não abrangendo outras condições clínicas e o período inicial do adoecimento. Tal desconhecimento interfere diretamente no planejamento e na qualidade da assistência prestada, haja vista que a falta de conhecimento, somada muitas vezes de uma resistência intrinsecamente enraizada no modelo curativista, implica práticas assistenciais desorganizadas e sem evidências científicas, tornando pacientes elegíveis em pacientes que experienciam condições inadequadas, sem alívio de sintomas e com medidas de prolongamento de vida que podem provocar sofrimentos intensos (Martins; Oliveira; Silva *et al.*, 2022).

Dessa maneira, os tratamentos curativos e paliativos não são excludentes, mas sim, complementares e integrados. O tratamento modificador da doença começa com maior intensidade a partir do diagnóstico, diminuindo em intensidade de acordo com a evolução da doença; inversamente proporcional ao tratamento paliativo, que inicia de maneira discreta e vai aumentando, conforme necessidade, sendo mais evidente com o avanço da complexidade (Lopes, 2023).

Como princípios dos cuidados paliativos (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021), destaca-se:

- 1) alívio da dor e do sofrimento físico, psicossocial, espiritual e existencial, incluindo o cuidado para familiares e cuidadores;
- 2) afirmação da vida e consideração da morte como processo natural;

- 3) não acelerar nem adiar a morte;
- 4) integrar os aspectos psicológicos e espirituais ao cuidado do paciente;
- 5) oferecer suporte para que o paciente permaneça ativo dentro das suas possibilidades até sua morte;
- 6) oferecer suporte aos familiares durante o adoecimento e no enfrentamento do luto;
- 7) abordagem multiprofissional das necessidades dos pacientes e de seus familiares;
- 8) melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso natural da doença;
- 9) ser iniciado o mais precocemente possível e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes.

Assim, um dos aspectos principais a serem destacados é a compreensão de que os CP não devem ser iniciados apenas quando o tratamento não atinge mais sua função curativa, mas sim desde o diagnóstico, conciliando a abordagem paliativa com o tratamento curativo (Lopes, 2023).

Em 2006, a revista *Critical Care Medicine* publicou um suplemento dedicado ao tema de CP em UTI, contemplando diversos dilemas vividos neste setor. Além da formação dos profissionais e a dificuldade em perceber que não pode mais atuar em direção à cura, há ainda a dificuldade de encarar a impotência diante da inevitabilidade da morte (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2012).

Os problemas ético-legais que permeiam estas decisões também influenciam a vivência destes dilemas, sendo alguns deles: comunicação insuficiente sobre as decisões de fim de vida; incapacidade de pacientes de participar nas discussões sobre seu tratamento; expectativas não realistas por parte dos pacientes e de seus familiares sobre o prognóstico ou eficácia do tratamento na UTI e falta de oportunidades para discussão sobre a forma como eles desejam receber os cuidados no final da vida (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2012).

Desde o início de século XXI, as questões relacionadas aos CP dentro da UTI passaram a ser cada vez mais discutidas em medicina intensiva, refletindo não só em uma mudança na qualidade de cuidado, mas também em uma crescente necessidade social e econômica de agir de forma diferente nestas situações (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

Terapias como ventilação mecânica, drogas vasoativas, hemodiálise e ressuscitação cardiopulmonar (RCP) são definidos como medidas artificiais de suporte avançado de vida (SAV) que não constituem primariamente um tratamento específico a uma doença, mas sim um suporte a órgãos e sistemas que não conseguem executar adequadamente as suas funções (Vincent; Moore; Bellomo *et al.*, 2022). Estas intervenções podem oferecer suporte vital em situações onde há expectativa de reverter uma doença aguda ou crônica descompensada. No

entanto, em situações onde estas expectativas não são mais viáveis, prolongam muitas vezes, de forma dolorosa, o processo de morrer (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

Quando o objetivo do tratamento é o conforto, elas podem ser entendidas como medidas fúteis, sendo que retirá-las ou limitar seu uso nestas circunstâncias passa a ser uma opção a ser considerada, mantendo ou intensificando apenas todos os cuidados que possam aliviar os sintomas de desconforto (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

Assim, sociedades médicas internacionais, nacionais e bioeticistas definem que quando as medidas de SAV não puderem mais oferecer benefício para o paciente, mas apenas prolongar de forma sofrida o seu processo de morrer, limitá-las ou retirá-las pode proporcionar ao paciente uma condição mais natural para enfrentar a sua morte, deixando de prolongar o processo de morte de forma artificial (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

Corroborando que a maioria dos documentos publicados, assim como as sociedades: *American Medical Association, American Thoracic Society, Society of Critical Care Medicine, United Kingdom General Medical Council, European Respiratory Society, European Society of Intensive Care Medicine, Société de Réanimation de Langue Française* reconhecem que retirar ou limitar SAV em uma situação de fim de vida são medidas eticamente equivalentes (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

No Brasil, é explícito no CFM que tais condutas só são éticas quando respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal, especialmente quando se trata de pediatria. Para tanto, desenvolver habilidades de comunicação, especialmente a habilidade de ouvir com empatia torna-se essencial (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

Considerando que a morte em pediatria é um evento não natural e normalmente não esperado, embora seja uma realidade inquestionável, a incidência de pacientes pediátricos portadores de condições clínicas complexas tem aumentado no mundo moderno. Nos EUA, aproximadamente 55 mil crianças e adolescentes entre 0-19 anos morrem anualmente decorrente destas condições, sendo que um terço das mortes ocorre no período neonatal, metade no primeiro ano de vida, e, um quarto ocorre entre 15 a 19 anos (Brito; Soares; Rocha *et al.*, 2015).

A evolução da medicina nos últimos 50 anos modificou o prognóstico e sobrevida de inúmeras doenças e a incorporação de novas tecnologias, tratamentos cada vez mais eficazes, desenvolvimento das diversas subespecialidades pediátricas aliadas à proliferação das Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), permitiram a sobrevivência de crianças que até pouco tempo eram consideradas inviáveis e morriam precocemente (Piva; Garcia; Lago, 2011).

Paralelamente, gerou-se um grupo de crianças portadoras de doenças crônicas com sequelas graves, dependentes de tecnologia e, muitas vezes, com uma reduzida expectativa de vida. Muitas dessas crianças acabam necessitando de repetidas internações hospitalares, inclusive na fase final da doença que antecede o óbito (Piva; Garcia; Lago, 2011).

A quase totalidade dos óbitos hospitalares em pediatria ocorre na UTIP, seguido em menor escala pelo centro cirúrgico, sala de emergência, unidade de oncologia e enfermarias pediátricas. Apesar de assistir uma população com alto risco de vida, as UTIP vêm apresentando um marcado declínio em suas taxas de mortalidade, situando-se hoje ao redor de 4 a 10% (Piva; Garcia; Lago, 2011).

Por outro lado, tem sido demonstrado que muitas crianças em fase terminal de doença irreversível quando internadas em UTIP acabam recebendo um tratamento centralizado na cura (que nesse caso é inalcançável), desconsiderando as reais necessidades nos momentos que antecedem o final de vida e considerando os CP tardiamente (Piva; Garcia; Lago, 2011), gerando prejuízo na terapêutica e promoção de qualidade de vida dessa família.

As crianças e adolescentes que possuem patologias que limitam a vida e que são potencialmente fatais merecem uma reavaliação do ponto de vista cultural e organizacional sobre qual é o objetivo do cuidado. Dessa forma, a partir do momento que a recuperação não é mais possível, deve-se oferecer dentro das possibilidades a melhor saúde possível aliada à melhor qualidade de vida, sendo que este cuidado e apoio devem ocorrer a longo prazo (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

De acordo com o Manual de Cuidados Paliativos (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021), é importante fazer a distinção entre os CP e o cuidado dos pacientes na sua terminalidade: os cuidados terminais se referem ao cuidado das crianças e seus pais durante o tempo que está intimamente relacionado com a sua morte (semanas, dias ou horas). O CP inclui o cuidado terminal, porém o cuidado ao paciente somente na terminalidade não completa todos os requisitos para os CP. Este conhecimento é importante, pois influencia a elegibilidade dos pacientes, norteia critérios e soluções adequados para um apropriado cuidado, principalmente no ambiente pediátrico.

Ao prestar assistência ao paciente pediátrico, devemos lembrar que, além de possuir características diferentes dos adultos, a criança ainda se encontra em processo de aprendizagem, de amadurecimento físico, emocional, cognitivo, social e espiritual, influenciando o surgimento de sintomas multidimensionais (Silvestri; Santos; Belini; *et al.*, 2021).

Dessa maneira, as intervenções oferecidas pelos CPP englobam três níveis: 1. Preocupações com sintomas físicos: dor, fadiga, agitação, náusea, vômitos e prurido; 2.

Preocupações psicossociais: identificação dos medos e preocupações da família e da criança com suporte necessário, preservação de uma comunicação de qualidade, identificação das expectativas e das vivências anteriores e necessidade de suporte comportamental e espiritual; 3. Preocupações espirituais (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).

Ainda de acordo com o Manual de Cuidados Paliativos (2021), a gestão dos diversos sintomas do final da vida em pediatria é um desafio a ser superado. Aliam-se aos problemas clínicos os problemas psíquicos, sociais e espirituais que também recebem pouca atenção, sendo que o subtratamento ocorre de uma forma global, havendo pouca disponibilidade de um atendimento correto ao paciente que necessita.

Institucionalmente, as barreiras podem ser superadas pelo desenvolvimento e implementação de protocolos clínicos, protocolos institucionais e procedimentos para os cuidados paliativos, final da vida e cuidados no luto (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021). Ademais, para que de fato ocorra, este tipo de cuidado, se faz necessário profissionais capacitados e integrantes de uma equipe interdisciplinar, que ofereçam um atendimento especializado e individualizado, atentando para as necessidades do indivíduo, em todas as dimensões da sua vida (Hoffmann; Vidotti; Oliveira *et al.*, 2023).

No âmbito das unidades críticas, o cuidado proporciona o bem-estar biopsicossocioespiritual da criança e família, por meio da relação empática, da competência técnica e da responsabilidade ética, além de orientar o processo de ressignificação do sentido da vida diante da presença de enfermidades (Dias; França; Batista *et al.*, 2022).

É papel da equipe interdisciplinar dedicar seus cuidados não para a cura ou controle da doença, mas sim, visando à melhor experiência durante a hospitalização. O alívio da dor (analgesia), por exemplo, é um direito de toda criança hospitalizada, mais ainda naquela em CPP. O alcance do alívio da dor pode se dar em duas dimensões: medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas. As farmacológicas são administradas com a finalidade de minimizar a dor de forma significativa, sendo que o manejo adequado da dor deve ser uma prioridade no planejamento (Dias; França; Batista *et al.*, 2022).

Já as medidas não farmacológicas, podem englobar dimensões da dor que vão muito além das sensitivas, podendo ser de caráter social, psicológico e emocional. Corroborando esse entendimento, correlaciona-se medidas como contato humano e apoio psicológico, fazendo com que a dor que não pode ser solucionada com medicamentos seja amenizada ou controlada, sendo o cuidado diferencial das crianças em contexto de CPP (Dias; França; Batista *et al.*, 2022).

Assim, os trabalhadores da equipe multidisciplinar têm por objetivo prestar a assistência visando à qualidade de vida e à manutenção do conforto e operando as diversas tecnologias no auxílio das funções fisiológicas. A promoção do conforto, o manuseio da dor e dos outros sintomas, assim como o suporte e educação para a família devem ser fundamentais no cuidado da criança em CP, dentro das condições em que a criança se encontra (Dias; França; Batista *et al.*, 2022).

Portanto, é necessário a compreensão de que, mesmo em cenários críticos, os CPP têm o objetivo de proporcionar conforto às crianças, por meio do alívio da dor e dos sintomas, englobando as necessidades biopsicossociais e espirituais, compreendendo suas crenças, valores e necessidades, para que o cuidado seja individualizado e adequado a cada caso.

Além disso, a garantia e o respeito aos princípios bioéticos da dignidade humana e autonomia do paciente são elementos constituintes dos fundamentos dos CP. Logo, essa abordagem ética permite o protagonismo da criança e suas famílias, envolvendo seus cuidados de saúde nos ambientes de terapia intensiva.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Cabe ressaltar que o estudo utilizou a PDT como referencial teórico e as análises tecidas foram discutidas sob a ótica dos escritos de Christophe Dejours.

4.1 A Psicodinâmica do Trabalho

O trabalho não é caracterizado somente como um meio de sobrevivência material, mas como configuração de uma socialização e construção de identidade. Considera-se que o trabalho pode favorecer a expressão da subjetividade das pessoas e resgatar ou promover a saúde conforme a organização e o processo laboral. Logo, a condição de saúde física e mental de uma pessoa não pode ser desvinculada de sua atividade profissional e do seu contexto laboral, atentando-se para os condicionantes e determinantes envolvidos nesta complexa relação entre saúde e trabalho (Dal’bosco; Floriano; Skupien *et al.*, 2020).

Em um contexto histórico, o trabalho passou por grandes transformações, que o fez assumir diferentes concepções ao longo do tempo. Muitas culturas entendiam o trabalho como algo divino, sagrado e destinado aos únicos sujeitos que fossem pré-determinados a esta ação. Já em outros contextos culturais, o trabalho era considerado como atividade menor, de pouca relevância à vida (Oliveira, 2019).

O Ocidente Clássico também contribuiu com duas concepções sobre o trabalho: o trabalho intelectual que foi destinado às pessoas das classes superiores e a cargos de chefia que possuíam o poder de ditar ordens e organizar o movimento do trabalho, e o trabalho braçal, destinado somente às classes inferiores, assumindo uma visão degradante, inferior e desgastante (Oliveira, 2019).

A partir do surgimento do capital na modernidade, o trabalho começou a ser vinculado a uma atividade remunerada e as ideias do taylorismo-fordismo foram implementadas, como a administração científica e a cadeia de montagem. Com o advento do capitalismo e a inserção das máquinas, o trabalhador passou a entender que a venda da sua mão de obra consistia no único modo de sobrevivência no pouco espaço no mercado de trabalho. O trabalho, então, foi resumido a mercadoria e a um instrumento de alienação, possuindo um caráter humilhante, monótono e submisso (Oliveira, 2019).

Até meados de 1914, o corpo era retratado como única causa pelos adoecimentos dos trabalhadores nas indústrias. A depressão era intitulada de “melancolia” e muitos trabalhadores eram acometidos pela doença, dessa maneira, a organização do trabalho se chocava com a saúde mental e o medo frequentemente estava associado ao trabalho (Dejours, 2012).

Entre os anos 1914-1968, o tema das condições de trabalho começa a ser reivindicado pela classe operária. Assim, a clínica do trabalho nasceu nos anos 70 do confronto entre a antropologia psicanalítica e a ergonomia, disciplina que se dedica ao estudo científico das condições de trabalho e das relações entre o homem e os objetos técnicos. A tarefa atribuída à clínica do trabalho consistia em elaborar uma teoria das relações entre o funcionamento psíquico e o trabalho e compreender porque este gerava sofrimento em certas pessoas e, em outras, prazer (Dejours, 2012).

A abordagem da PDT foi apresentada por Christophe Dejours, médico especialista em medicina do trabalho e em psiquiatria e psicanálise, através da publicação de “*Travail: Usure Mentale. Essai de Psychopathologie du Travail*”, em 1980, traduzido no Brasil com o nome de “A Loucura do Trabalho: Estudo de Psicopatologia do Trabalho”, em 1987. Esse trabalho trouxe um novo olhar para a compreensão das relações entre trabalho e saúde psíquica do trabalhador e passou a ser entendida como um importante referencial para a área da clínica e da saúde mental no trabalho (Giongo; Monteiro; Sobrosa, 2015).

Conforme Mendes (2007), o percurso da PDT foi caracterizado por três fases diferentes. O primeiro momento teve início na década de 80, denominava a teoria como psicopatologia do trabalho e buscava compreender o sofrimento e o modo como os trabalhadores lidavam com ele. Com a décima edição da mesma obra na década de 90, o enfoque da teoria passou a ser o estudo das vivências de prazer e de sofrimento no trabalho, pensando nas nuances do trabalho prescrito e do trabalho real, além de considerar a construção da identidade do trabalhador. E, no final da década de 90, ocorreu a consolidação da PDT como abordagem científica, que passou a estudar as novas configurações das organizações do trabalho, as estratégias defensivas, as patologias sociais e o sentido das vivências de trabalho.

É através da análise psicodinâmica das vivências do trabalhador relacionadas à organização do trabalho que se dá o entendimento dos processos atrelados à saúde/doença no trabalho. Neste contexto, a organização do trabalho representa uma realidade social enquanto mobiliza, e é mobilizada pelo trabalhador, que por sua vez, coloca sua subjetividade e constitui a intersubjetividade no trabalho (Giongo; Monteiro; Sobrosa, 2015).

Tendo em vista esta perspectiva, uma das principais contribuições da PDT é a de expor os efeitos que a organização do trabalho pode gerar na saúde mental do trabalhador, além de oferecer instrumentos para que estes efeitos sejam identificados ainda no campo pré-patológico, possibilitando atuações preventivas e capazes de compreender e intervir nos processos de saúde/doença mental no trabalho (Giongo; Monteiro; Sobrosa, 2015).

A carga de trabalho é dividida em dois setores, conforme Dejours (2018): carga física e carga mental. A carga psíquica nada mais é do que a mistura de fenômenos de ordem neurofisiológica e psicofisiológica. Tratando-se de carga psíquica ou mental, não é possível quantificar uma vivência, que é em primeiro lugar e antes de tudo, qualitativa. O prazer, a satisfação (que diminuem a carga psíquica), a frustração, a agressividade (que aumentam a carga psíquica), dificilmente se deixam dominar por números.

Se a relação do profissional com a organização das atividades é favorável, o trabalho pode ser fonte de prazer e satisfação. Para que o trabalhador vivencie esse prazer no trabalho é necessário que as exigências da atividade correspondam às necessidades do sujeito ou que este possa expressar sua subjetividade, participando da escolha do ritmo de trabalho e modificando a sua organização de acordo com a própria vontade (Dejours, 2012).

O prazer pode manifestar-se como um sentimento benéfico relacionado à estabilidade psíquica do trabalhador a partir do momento que supera as dificuldades impostas pelo trabalho, através de habilidades adquiridas e ações de resolutividade em seu meio profissional. Conforme Dejours (2012), o prazer no trabalho caracteriza-se como um estado marcado pela adequação da carga psíquica, ou seja, o prazer provém da conexão entre trabalho, necessidades e desejos psicológicos do trabalhador e relaciona-se intimamente com o uso da inteligência, iniciativa, criatividade, autonomia e possibilidade de se expressar, o que oportuniza a valorização e o fortalecimento da identidade pessoal.

A PDT mostra que o prazer laboral pode ser obtido por via direta, decorrente da identificação com o trabalho, ou por via indireta, a partir de novo significado de sofrimento no trabalho, estando estritamente relacionado à mobilização subjetiva. Um trabalho que oferece oportunidade para que o trabalhador se sinta valorizado e reconhecido favorece a vivência de prazer, o que é profundamente benéfico à sua saúde (Dejours, 2011).

O sofrimento, por sua vez, é considerado uma experiência emocional desagradável associada a sentimentos como impotência, insatisfação e estresse. Assim, a organização laboral e as condições de prescrição do trabalho associadas a característica do indivíduo podem resultar no surgimento do sofrimento (Dejours, 2012).

Assim, o trabalho não deve se constituir em fonte de infortúnio, mas proporcionar às pessoas condições de desenvolvimento de suas potencialidades e de auto realização. Para Dejours (2012), prazer e sofrimento no trabalho são estritamente indissociáveis, pois em um mesmo ambiente e organização laboral é possível encontrar tanto elementos estruturais positivos, quanto negativos.

Existem dois tipos de sofrimento: o sofrimento criativo e o patogênico. O sofrimento criativo se caracteriza pela mobilização do indivíduo em transformar o sofrimento em algo benéfico para si. Mas para que isso seja possível, é necessário que encontre certo grau de liberdade na organização do trabalho, a qual permita a possibilidade de negociação entre as imposições organizacionais e o desejo do trabalhador (Dejours, 2012).

O sofrimento patogênico, por sua vez, estaria relacionado à ausência de flexibilização da organização do trabalho, impedindo que o sujeito encontre maneiras de extravasar as cargas emocionais provenientes dos desafios de suas atividades laborais (Dejours, 2012).

Nesse sentido, um dos fatores para a ocorrência de sofrimento para o trabalhador se deve à lacuna existente entre o trabalho prescrito e o real sendo habitual a existência de acontecimentos inesperados nas situações de trabalho, mesmo que a organização seja bem estruturada, sempre haverá uma discordância entre o prescrito e a realidade concreta da situação (Dejours, 2012).

Conforme Dejours (2012), o trabalho prescrito compreende a execução da atividade a ser cumprida, orientando-se por diretrizes previamente instituídas pela organização e acatando um contexto convencional, sem considerar as variáveis que surgem na rotina ocupacional. Já o trabalho real representa as situações não operacionalizadas no trabalho prescrito, situações que acontecem inesperadamente no ato da execução da tarefa, ou seja, o que efetivamente o trabalhador executa.

Ademais, há um desequilíbrio inevitável entre o trabalho prescrito ao trabalhador e o trabalho real realizado por ele. Dessa forma, os trabalhadores nunca se limitam à execução restrita das prescrições, ou seja, eles reajustam a prescrição, transformam as ordens, não significando “indisciplina”, mas para fazer bem o seu trabalho, denominando-se trabalho efetivo (Dejours, 2012).

Assim, de acordo com a abordagem do trabalho pela ergonomia e a clínica do trabalho, é preciso inventar e acrescentar de si mesmo às prescrições. A contribuição de suas inteligências individuais somada a qualidade de seu desempenho, quando validada pelos outros, resulta em reconhecimento (Dejours, 2012).

O reconhecimento, por sua vez, é indissociável do comprometimento subjetivo na tarefa e tem um impacto considerável sobre a identidade (Dejours, 2012). Segundo Duarte, Glanzner, Bagatini *et al.* (2021), o reconhecimento repercute na apreciação do esforço e do sofrimento investido para a prestação do cuidado, e possui um impacto direto na construção da identidade do trabalhador, pois os esforços empreendidos na prática laboral adquirem sentido, e o profissional evidencia que não somente colaborou, mas obteve um retorno pelo seu trabalho.

Assim, uma parte do sofrimento é transformada em prazer, evitando o adoecimento do profissional.

Outro aspecto muito importante na procura do prazer e defesa diante do sofrimento no trabalho é a mobilização subjetiva, definida como o processo pelo qual o trabalhador se engaja no trabalho e consegue fazer uso da subjetividade, inteligência prática e do coletivo de trabalho para transformar os fatores da organização do trabalho causadores de sofrimento (Dejours, 2012).

Nesta abordagem, a organização do trabalho ocupa um papel fundamental no entendimento dos processos de saúde/doença do trabalhador, sendo sua rigidez inversamente proporcional à saúde mental. O conceito de organização do trabalho pode ser dividido em duas esferas, sendo uma delas caracterizada pela divisão do trabalho e a outra pela divisão dos homens (Dejours, 2018).

Na divisão do trabalho estão os aspectos relacionados à organização das tarefas, aos processos prescritos e ao modo de produção. Na divisão dos homens, estão as responsabilidades relacionadas ao trabalho, as relações de poder, as hierarquias, o grau de autonomia nas atividades e as possibilidades de cooperação e comunicação. Neste contexto, a organização do trabalho representa uma realidade social que coloca em prática a subjetividade e a intersubjetividade do trabalhador (Giongo; Monteiro; Sobrosa, 2015).

No contexto do trabalho em saúde, os trabalhadores da terapia intensiva desempenham funções em que coexistem prazer e sofrimento na sua atividade assistencial. Uma das grandes dificuldades enfrentadas por esses profissionais é voltada ao enfrentamento psicológico por conta das situações que eles vivenciam no seu dia a dia de trabalho. Eles presenciam altos níveis de desgaste emocional devido à interação com as crianças que atendem, constantes internações, muitas vezes acompanhando o sofrimento, como a dor, a doença e a morte dessa criança (Silvestri; Santos; Belini; *et al.*, 2021).

Em áreas que prestam atendimento a crianças em CP, o cuidado constitui-se uma tarefa complexa, pois abrange sentimentos influenciados por elementos como a improbabilidade da cura e a frustração da perspectiva de vida que se espera para uma criança. Assim, o exercício dos trabalhadores da equipe multidisciplinar pode favorecer riscos ocupacionais, podendo ser gerador de sofrimento e prazer (Fonseca; Sá, 2020).

Assim, uma das principais contribuições da PDT é a de expor os efeitos que a organização do trabalho pode gerar na saúde mental do trabalhador, além de oferecer instrumentos para que estes efeitos sejam identificados ainda no campo pré-patológico,

possibilitando atuações preventivas e capazes de compreender e intervir nos processos de saúde/doença mental no trabalho (Dejours, 2012).

Portanto, a PDT permite o estudo dos processos que proporcionam ao sujeito a incansável busca de si mesmo dentro da organização de trabalho. O sujeito entende que o equilíbrio no ambiente laboral nada mais é que o encontro de si na atuação que ele desempenha, mas que para isso ele precisa estar preparado para utilizar-se de recursos internos, aliados a um apoio da instituição, e que tudo isso deve ser resultado da sua relação com o compromisso com a sua organização.

5 METODOLOGIA

5.1 Tipo de estudo

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva e tem como referencial teórico a Psicodinâmica do Trabalho, proposta por Christophe Dejours. Além disso, esta pesquisa utilizou o instrumento *COnsolidated Criteria for REporting Qualitative research* (COREQ), a fim de fortalecer o rigor metodológico. Esta ferramenta contempla 32 critérios em três domínios: equipe de pesquisa e reflexividade, conceito do estudo, análise e resultados que permitem a qualificação do estudo (Tong; Sainsbur; Craig, 2007).

A pesquisa qualitativa preocupa-se com o que não pode ser quantificado, ou seja, o que corresponde às relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Ela visa explorar os significados das ações e relações humanas, lado que não é perceptível e captável em estatísticas (Minayo, 2014).

Dessa maneira, a pesquisa qualitativa, busca a “intensidade do fenômeno”, ou seja, trabalha com a dimensão sociocultural que se expressa por meio de crenças, valores, opiniões, representações, costumes, comportamentos e práticas (Minayo, 2017).

Diante desse contexto, a escolha por uma pesquisa qualitativa se deve pelas peculiaridades de uma abordagem baseada na exploração do material diante de entrevistas e observações. Entende-se que esse fenômeno permite uma análise minuciosa das características e especificidades da relação dos trabalhadores para com seu ambiente laboral, sobretudo fatores e as relações sociais desse contexto (Minayo, 2017). A partir daí, foi possível analisar as vivências do trabalhador, e por meio do referencial da PDT, analisar criticamente a organização, o prazer, o sofrimento e suas estratégias de mediação no trabalho.

5.2 Delimitação do estudo

5.2.1 Local de estudo

O estudo foi realizado na UTIP do HCPA. Esta UTIP é composta por 15 leitos, que atendem demandas em diversas especialidades em condições de pós-operatórios de cirurgias de grande porte, e em situações clínicas de maior complexidade, abrangendo intercorrências clínicas que necessitem de ventilação mecânica invasiva e suporte hemodinâmico intensivo. Tal motivo influenciou a escolha do local, pois o contato direto e prolongado com essas crianças gera sentimentos que podem ser positivos, motivadores e inspiradores para os trabalhadores, ou podem ser negativos ao passo de impossibilitar o profissional de assimilar o potencial gerador de sofrimento causado.

Vale ressaltar que o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) caracteriza como criança àquele com idade até doze anos incompletos, e adolescente àquele que estiver entre doze e dezoito anos de idade. Para além do recorte etário, a definição das categorias criança e adolescente são construídas socialmente.

O HCPA é um hospital geral de referência na região de Porto Alegre, que presta assistência de atenção terciária. Atua desde 1971, e é uma instituição pública integrante da rede de hospitais universitários do Ministério da Educação (MEC) e está vinculado academicamente à UFRGS, produzindo pesquisas que introduzem novos conhecimentos, técnicas e tecnologias que visam o benefício da sociedade como um todo e a formação de pesquisadores (HCPA, 2022).

5.2.2 Participantes do estudo

A escolha dos entrevistados foi do tipo intencional por convite, envolvendo a seleção de participantes que compartilham características particulares e têm o potencial de fornecer dados ricos, relevantes e pertinentes à questão de pesquisa (Polit; Beck, 2011).

A UTIP possui aproximadamente o seguinte quantitativo de profissionais contratados ativos: 23 enfermeiros, nove fisioterapeutas, 66 técnicos de enfermagem, 23 médicos, uma nutricionista, uma assistente social, uma psicóloga.

Foram convidados a participar do estudo cinco trabalhadores de cada categoria profissional da equipe multidisciplinar que atendessem aos critérios de seleção para o estudo, exceto as profissões que foram convidados um: nutrição, psicologia e serviço social, pois se trata de apenas um profissional contratado para os atendimentos da UTIP. Optou-se pela escolha desses profissionais devido à proximidade no cuidado às crianças em cuidados paliativos no contexto da UTIP. Todos os turnos (manhã, tarde, noite e final de semana) foram incluídos para melhor compreensão das repercussões do cuidado paliativo nos trabalhadores.

A amostra final poderia ser menor que a estipulada caso se atingisse a saturação dos dados, ou seja, momento em que a coleta da pesquisa em campo não trouxesse novos e/ou distintos esclarecimentos e resultados para o objetivo em questão (Minayo, 2017).

5.2.2.1 Critérios de inclusão: Foram incluídos os trabalhadores da equipe multidisciplinar que atuassem no cenário do estudo em regime de contrato efetivo de, no mínimo, seis meses e que cuidam ou já cuidaram de criança em cuidados paliativos hospitalizada na UTIP.

5.2.2.2 Critérios de Exclusão: Foram excluídos do estudo trabalhadores da equipe multidisciplinar que estivessem em licença saúde ou licença gestação.

5.3 Coleta das informações

5.3.1 Observação participante

Em um primeiro momento foi apresentado o projeto às chefias das UTIP e após a ciência das mesmas sobre os propósitos e finalidades da pesquisa, o estudo foi iniciado com a realização de uma observação participante, com duração de 50 horas junto a equipe multiprofissional da UTIP, com o objetivo de imersão no campo de estudo.

Essas observações foram guiadas por um Roteiro de Observação (Apêndice A) que delimitou os aspectos relevantes a serem focados, garantindo um registro direcionado através de escritos antes, durante e após as observações, em formato de diário de campo, permitindo capturar nuances contextuais e interpretações que enriqueceram a compreensão do fenômeno estudado.

Este instrumento, conforme preconiza Minayo (2014), destinam-se ao registro de informações que complementam as entrevistas, abrangendo conversas informais, comportamentos, eventos, gestos e expressões, bem como as impressões e análises do pesquisador sobre a realidade observada. O roteiro de observação também foi flexível com as demandas e necessidades que se apresentaram durante o período de coleta de dados.

Esse período contou com 16 dias de observação e cada trecho extraído dos diários de campo foi identificado de forma clara e rastreável pela sigla "OBS." (de "observação"), seguida da data da observação e o turno em que ocorreu (manhã, tarde ou noite), por exemplo: "OBS. 01/10/2025, tarde", "OBS. 02/10/2025, manhã". Essa padronização facilitou a organização e a análise dos dados observacionais.

Conforme Triviños (2011), a descrição constitui uma fase fundamental da observação, para a qual o autor propõe técnicas específicas: registrar os comportamentos, ações e atitudes precisamente como foram observados; caracterizar os sujeitos por seus traços observáveis, evitando generalizações abstratas; detalhar o ambiente físico; relatar as atividades específicas em curso; transcrever os diálogos relevantes; e, subsequentemente, elaborar anotações de campo de natureza reflexiva, integrando as impressões e interpretações do observador.

Dejours (2012) relata que as questões levantadas pelo pesquisador em conversas e observações feitas informalmente já produzem um efeito sobre as relações sociais de trabalho, abrindo um espaço para a ação. Dessa forma, a observação se tornou um importante recurso, com potencial de fornecer descrições detalhadas das atividades, da dinâmica e dos participantes do serviço, enriquecendo a avaliação qualitativa.

5.3.1 Entrevistas semiestruturadas

A coleta das informações do presente estudo também foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas (Apêndice B), contendo questões fechadas sobre o perfil dos profissionais e questões abertas sobre os fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas individuais e coletivas diante dos cuidados paliativos no cenário da UTIP, onde os participantes puderam discorrer sobre o tema proposto e complementar com mais informações, caso achassem necessário. Foi realizado um teste piloto com dois trabalhadores a fim de verificar se as questões estavam adequadas, visando a compreensão do profissional entrevistado. O roteiro não sofreu alteração e essas entrevistas não fizeram parte do quantitativo final.

Foi realizado um primeiro contato com os profissionais da equipe multiprofissional de forma presencial, onde foi feito o convite para participação. Confirmado o interesse do participante, foi agendado um dia de preferência do entrevistado, fora de sua jornada de trabalho, para a realização da entrevista de forma presencial e em local reservado e sem ruídos, na sala de reuniões da UTIP do HCPA.

As entrevistas ocorreram durante o período de agosto a outubro de 2025 e o tempo de duração foi entre 15 a 45 minutos. Foram aplicadas pela pesquisadora do estudo, com auxílio de uma bolsista de iniciação científica, ambas com experiência em coleta de dados de pesquisa qualitativa, e que não possuíam relação interpessoal prévia com a equipe do estudo, a fim de não gerar viés no estudo.

As entrevistas ocorreram de maneira presencial, em uma sala reservada da unidade, sem ruídos e com garantia da privacidade, sendo gravadas e transcritas na íntegra para análise e leitura do material. Somente a autora possuiu acesso às respostas dos entrevistados, as quais foram codificadas para preservação da privacidade e manter o anonimato. Ao final de cada entrevista, também foi questionado sobre a vontade do entrevistado de ouvir o conteúdo das suas respostas. Os profissionais entrevistados foram codificados pela letra “T” de “trabalhador, seguida pelo número de acordo com a sequência em que ocorrerão, por exemplo: “T1”, “T2”, “T3” e assim, sucessivamente.

Portanto, 21 trabalhadores atenderam a todos os critérios e aceitaram participar da pesquisa, sendo que ao final do estudo, não houveram desistências e a coleta encerrou-se a partir do momento em que as entrevistas não trouxeram novas informações, atingindo a saturação.

5.4 Análise das informações

As informações foram analisadas de acordo com a Análise Temática, proposta por Minayo (2014), na qual se desdobrou em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

A primeira etapa consistiu na retomada dos objetivos iniciais da pesquisa. Durante essa fase foi realizada uma leitura flutuante para contato direto e intenso com o material de campo, a fim de compreender o conteúdo e constituir um *corpus*, que corresponde ao conteúdo estudado em sua totalidade e retomando o processo da etapa exploratória, tendo como parâmetro a leitura exhaustiva do material e as indagações iniciais. Ainda nessa fase, determinaram-se a unidade de registro, as unidades de contexto, a modalidade de codificação e os conceitos teóricos mais gerais que orientarão a análise (Minayo, 2014), tais como: “flexibilização de visitas”, “conforto”, “procedimentos invasivos”, “elaborar o luto”, “ludicidade”, “reconhecimento”, “*round* multidisciplinar”, “ajuda dos colegas”, “confusão entre conceitos”, “sofrimento da família”, “obstinação terapêutica”, “invasão do trabalho no espaço pessoal”, “reconhecimento da equipe”, “terapia”, “momentos com amigos e família” e “momentos de trocas com os colegas”.

A segunda etapa incluiu o agrupamento de categorias onde o conteúdo foi organizado, visando alcançar a compreensão do texto. A categorização se constitui em um processo de redução do texto, resultando na classificação e agregação dos dados, separando-os em categorias responsáveis pela especificação dos temas (Minayo, 2014), onde emergiram quatro: “Organização laboral dos trabalhadores da UTIP”, “Fatores geradores de prazer nos trabalhadores”, “Fatores geradores de sofrimento nos trabalhadores” e “Estratégias defensivas utilizadas pelos trabalhadores”.

Por fim, na terceira etapa, evidencia-se as informações obtidas e a partir dela, foram realizadas inferências e interpretações (Minayo, 2014), relacionando-as em torno das dimensões teóricas propostas por Dejours e a PDT, servindo como referencial teórico para o estudo.

5.5 Aspectos éticos

O estudo foi iniciado após apreciação e aprovação da Comissão de Pesquisa (COMPESQ) da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da UFRGS, posteriormente pela Plataforma Brasil e também pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HCPA, com o nº 7.726.407 (CAAE: 89877125.9.0000.5327).

Os trabalhadores entrevistados tiveram sua identidade preservada, sendo respeitados os itens que constam na Resolução nº 466/12 (Brasil, 2012), na Resolução nº 510/16 (Brasil, 2016),

na Resolução nº 674/22 (Brasil, 2022) do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e na mais recente Lei nº 14.874/24 (Brasil, 2024), que dispõe sobre as normas éticas que regulamentam a pesquisa envolvendo seres humanos.

Os dados pessoais obtidos foram manejados respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (Brasil, 2018).

Foi fornecido, lido e elucidado para cada participante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A), e o mesmo prosseguiu para a fase de entrevistas após ter confirmado o interesse e concordado com o mesmo, assinando-o em duas vias de igual teor, permanecendo uma cópia com o pesquisador e a outra com o entrevistado.

O TCLE continha informações referentes ao estudo como objetivos, riscos e benefícios bem como a garantia do caráter voluntário de participação, a manutenção de seu anonimato e a possibilidade de retirar seu consentimento a qualquer etapa do estudo sem nenhuma penalização ou prejuízo, além da não interferência em seu vínculo empregatício ou relação com avaliação de desempenho.

Os riscos relacionados à participação foram referentes ao possível desconforto ou constrangimento ao abordar o conteúdo das perguntas, por ser um relacionado ao (possível fator de sofrimento do) ambiente laboral. Não existiram benefícios diretos aos participantes, porém, os resultados contribuíram para o conhecimento sobre o assunto estudado, e poderão beneficiar futuros participantes, a partir da disseminação dos resultados, com estratégias individuais e coletivas que qualifiquem os processos de trabalho, sobretudo os geradores de sofrimento.

O material oriundo da pesquisa ficará sob responsabilidade da pesquisadora e será armazenado por um período de cinco anos, garantindo a sua integridade, permitindo a análise posterior dos dados e a possibilidade de responder eventuais dúvidas ou solicitações do CEP. Após esse período, as informações serão destruídas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação partiu do pressuposto de que a carga psíquica dispendida no cuidado da criança em CP é elevada, sobretudo em cenário de altas tensões, como da terapia intensiva. E que o cuidado à criança em medidas paliativas pode ser influenciado pelas condições laborais, podendo repercutir diretamente na vida e na qualidade da assistência ofertada pelos trabalhadores da equipe que atuam nesses setores. Com este estudo, pode-se analisar os fatores que geram prazer e sofrimento aos trabalhadores e as estratégias defensivas utilizadas por eles para amenizar a carga psíquica advinda do trabalho realizado.

Os achados da investigação evidenciaram que a organização do trabalho na UTIP é dinâmica e complexa, e com isso, os trabalhadores encontraram prazer na autonomia, na organização do trabalho e nos diversos momentos que cuidaram de crianças em cuidados paliativos e, mesmo sob cenários de mobilização psíquica, reconhecem a parcela de satisfação retribuída pelo labor.

Esses aspectos reverberam sentimentos de prazer a partir do momento que conseguem perceber que a flexibilizações de rotinas laborais fazem parte da subjetividade e liberdade do seu trabalho. Além disso, por mais que a assistência com crianças paliativas demande carga psíquica devido ao envolvimento no cuidado, o auxílio na elaboração do luto da família nesse momento promove uma despedida digna da criança, trazendo o sentimento de pertencimento e sensação de dever cumprido aos entrevistados. Ademais, a participação ativa no cuidado é uma das condições geradoras de prazer e satisfação, pois os desfechos, na maioria das vezes, são decorrentes da participação e investimento de um trabalho coletivo.

Os fatores de sofrimento surgem a partir do momento em que a indefinição sobre paliatividade e terminalidade é percebida pelos trabalhadores quando a criança já poderia ser beneficiada pelos cuidados de conforto pressupostos dos CPP, gerando muitas vezes uma inevitabilidade da terminalidade na UTIP acompanhado pelo sofrimento da família. Esse cuidado e envolvimento com essas crianças e suas famílias faz com que haja repercussão do ambiente laboral no espaço da vida pessoal desses trabalhadores, podendo gerar sintomas psicossomáticos e adoecimento ao profissional.

Já, em relação às estratégias defensivas, os trabalhadores utilizaram diferentes mecanismos para amenizar a carga psíquica gerada a partir do cuidado a essas crianças. No contexto do ambiente laboral, elas utilizam o diálogo com colegas em grupo e a ginástica laboral como um momento que traz leveza ao labor. Ademais, os profissionais entrevistados também citaram estratégias individuais como psicoterapia, meditação e momentos com pessoas

afetivamente próximas em busca de fuga do mundo laboral. O distanciamento emocional, a partir do silenciamento de grupos institucionais em aplicativos de mensagens e a restrição do acesso de familiares às redes sociais também é um mecanismo de proteção utilizada por esses trabalhadores.

Evidenciou nesse estudo a falta de espaço coletivo institucional destinado ao compartilhamento desses sentimentos entre os trabalhadores. Tal aspecto é importante, conforme discutido previamente por Dejours, uma vez que possibilitam a ressignificação do sofrimento, permitindo que as experiências individuais sejam reconhecidas e compartilhadas pelo grupo, trazendo sentido para o trabalho.

Ressalta-se, a partir desta pesquisa, que o trabalho gera repercussão tanto na própria vida laboral como no espaço pessoal dos trabalhadores, e a utilização de estratégias, muitas vezes, são formas de controlar e diminuir a carga psíquica, uma vez que crianças em CPP demandam uma abordagem de cuidado diferente daquelas hospitalizadas por condições clínicas agudas, reproduzindo sentimentos de sofrimento e estresses nesses profissionais.

Dessa maneira, é necessário estabelecer programas dentro da instituição de saúde que acolham o trabalhador, visando o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento saudáveis. Ações que valorizem o vínculo e/ou afeto podem ser o alicerce para promoção de cuidado dos trabalhadores no ambiente laboral, propiciando espaços para o compartilhamento de percepções e experiências onde as pessoas tenham momentos para a fala e escuta.

É importante ressaltar que o presente estudo apresenta limitação, como o período curto de coleta de dados no que se refere a carga horária de observação. Embora esse período tenha possibilitado a compreensão de aspectos relevantes do cotidiano de trabalho e das interações entre os trabalhadores, um tempo maior de observação poderia ampliar a possibilidade de acompanhamento de mais momentos com crianças hospitalizadas em CPP, devido ao cenário apresentar em sua maioria, crianças hospitalizadas por condições agudas durante o período de coleta de dados.

Portanto, a realização deste estudo oportunizou conhecer as especificidades diante da organização, sentimentos de prazer e sofrimento no trabalho, e as estratégias defensivas verbalizadas pelos trabalhadores da equipe multidisciplinar no cuidado de crianças em cuidados paliativos no contexto da terapia intensiva à luz da PDT. O estudo promove a tentativa de auxiliar e proporcionar aos gestores da instituição, subsídios e ferramentas para articulação e implementação de práticas que proporcionem reflexão sobre o tema no ambiente laboral, de acordo com as necessidades dos trabalhadores, que se encontram em cenários críticos e que

necessitam ofertar um cuidado pautado na promoção da qualidade de vida para crianças no cenário da paliatividade.

REFERÊNCIAS

Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Panorama dos Cuidados Paliativos no Brasil. São Paulo: ANCP, 2018. Disponível em: <https://paliativo.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Panorama-dos-Cuidados-Paliativos-no-Brasil-2018.pdf>. Acesso em: 14 de mai. 2024.

BOTTINI, Fabio Faiad; PAIVA, Kely César Martins de; GOMES, Ricardo C. Individual resilience, pleasure, and suffering at work and organizational links: reflections and perspectives of research for the public sector. **Cad. EBAPE.BR**. v. 19, n. 1, p. 45-57, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/M88nX53cmgcDvy3GVPHmSMR/?lang=pt>. Acesso em: 23 jan. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos. Diário Oficial [da] União. Brasília: Distrito Federal, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 23 jan. 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. Saúde Legis.Brásilia: Distrito Federal, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html. Acesso em: 23 jan. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, 14 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.html. Acesso em: 23 jan. 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução no 674, de 6 de maio de 2022 (*). Dispõe sobre a tipificação da pesquisa e a tramitação dos protocolos de pesquisa no Sistema CEP/Conep. Diário Oficial [da] União. Brasília: Distrito Federal, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/atos-normativos/resolucoes/2022/resolucao-no-674.pdf/view>. Acesso em: 13 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024**. Dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Presidência da República. Casa Civil. Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114874.htm. Acesso em: 28 de jan. 2025.

BRITO, Mychelangel de Assis; SOARES, Erida de Oliveira; ROCHA, Silvana Santiago da; FIGUEIREDO, Maria do Livramento Fortes. Cuidados paliativos em pediatria: um estudo reflexivo. **Rev enferm UFPE on line.**, Recife, v. 9, n. 3, p. 7155-60, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/article/download/10446/11258/21474>. Acesso em: 27 jan. 2024.

CARDOSO, Soraya Bactuli; OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos; SOUZA, Tania Vignuda de; CARMO, Sandra Alves do; NASCIMENTO, Luciana de Cassia Nunes. Transformações da

ambiência de Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica na perspectiva dos enfermeiros. **Rev Min Enferm.** v, 26, p. e-1468, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/reme/article/view/40562>. Acesso em: 27 jan. 2024.

CASTILHO, R. K.; SILVA, V. C. S. da; PINTO, C. da S. (ed.). **Manual de cuidados paliativos**. 3. ed. São Paulo: Academia Nacional de Cuidados Paliativos; Atheneu, 2021.

DAL'BOSCO, Eduardo Bassani; FLORIANO, Lara Simone Messias; SKUPIEN, Suellen Vienscoski; ARCARO, Guilherme; MARTINS, Alessandra Rodrigues et al. Mental health of nursing in coping with COVID-19 at a regional university hospital. **Rev Bras Enferm.**, Rio de Janeiro, v. 73, n. 2, p. 1-7, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/ck98YrXKhsh6mhZ3RdB8ZVx/>. Acesso em: 29 jan. 2024.

DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian; BETIOL, Maria Irene Stocco. **Psicodinâmica do trabalho**: contribuições da Escola Dejouriana a análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas; 2011.

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho estudo de psicopatologia do trabalho. 6th ed. São Paulo, SP: Cortez; 2018. 158p.

DEJOURS, Christophe. Psicodinâmica do trabalho e teoria da sedução. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 17, n. 3, p. 363-71, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/ZCgmnvttLdFqdzFb3tdZ3zt/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 29 jan. 2024.

DEJOURS, Christophe. Trabalho vivo, v. 2: Trabalho e emancipação. Editora Blucher, 2022.

DIAS, Thainá Karoline Costa; FRANÇA, Jael Rúbia Figueiredo de Sá; BATISTA, Patrícia Serpa de Souza, RODRIGUES, Mariana de Sousa Dantas; LUCENA, Pablo Leonid Carneiro; COSTA, Brunna Hellen Saraiva. Assistência de Enfermagem à criança com câncer em cuidados paliativos: scoping review. **REME - Rev Min Enferm.** v. 26, p.e-1448, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/reme/article/view/39445/30897>. Acesso em: 18 de mar. 2025.

DUARTE, Maria de Lourdes Custódio; GLANZNER, Cecília Helena; BAGATINI, Mariana Mattia Correa; SILVA, Daniela Giotti da; MATTOS, Larissa Gomes de. Pleasure and suffering in the work of nurses at the oncopediatric hospital unit: qualitative research. **Rev Bras Enferm.** v. 74, Suppl 3, p. 1-7, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/WjrYRztZt8qM73Gt7K4TH6R/abstract/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 21 de mai. 2024.

FONSECA, Maria Liana Gesteira; SÁ, Marilene de Castilho. The intangible in the production of care: the exercise of practical intelligence in an oncology ward. **Ciência & Saúde Coletiva.** v. 25, n. 1, p. 159-68, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/CRDQTSp7XkBdnLZxTGnCcJH/?lang=en>. Acesso em: 29 jan. 2024.

GUARIENTO, Laura Pombani Luz; MONTEZELI, Juliana Helena; GASTALDI, Andréia Bendine; RIBEIRO, Benedita Gonçalves de Assis; SIGNOLFI, Rafaela Rossi. Psicodinâmica do trabalho da equipe multidisciplinar de um centro de tratamento de queimados. **Rev. bras.**

Queimaduras. v. 23, n. 4, p. 169-78, 2024. Disponível em: <http://www.rbqueimaduras.com.br/details/589/pt-BR/psicodinamica-do-trabalho-da-equipe-multidisciplinar-de-um-centro-de-tratamento-de-queimados>. Acesso em: 29 jan. 2026.

GIONGO, Carmem Regina; MONTEIRO, Janine Kieling; SOBROSA, Gênesis Marimar Rodrigues. Psicodinâmica do trabalho no Brasil: revisão sistemática da literatura. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 23, n. 4, p. 803-14, 2015. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2015000400002. Acesso em: 21 de mai. 2024.

GUIRRO, Úrsula Bueno do Prado; CASTILHO, Rodrigo Kappel; CRISPIM, Douglas. **Atlas de Cuidados Paliativos no Brasil**. 1ed. São Paulo, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2023. Disponível em: <https://cuidadospaliativos.org/uploads/2024/1/Atlas-ANCP.pdf>. Acesso em: 28 de jan. 2025.

Hospital De Clínicas De Porto Alegre (HCPA). Início. Institucional. Apresentação. Porto Alegre: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://www.hcpa.edu.br/institucional/institucional-apresentacao>. Acesso em: 23 jan. 2024.

HOFFMANN, Maria Cristina C. L.; VIDOTTI, Janaína de Fátima; OLIVEIRA, Júlia de Paula; POLEJACK, Larissa. Cuidados paliativos e políticas públicas no Brasil: aspectos conceituais e históricos. **Rev. Psicol Saúde e Debate**. v. 9, n. 2, p. 473-89, 2023. Disponível em: <https://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/998>. Acesso em: 14 de mai. 2024.

KLUGER, Benzi M.; ARNOLD, Robert M. The Total Enjoyment of Life: A Framework for Exploring and Supporting the Positive in Palliative Care. **J Palliat Med**, v. 26, n. 10, p. 1322-26, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10541933/>. Acesso em: 15 de jan. 2026.

LOPES, Fernanda Gomes. A moralidade das decisões médicas em cuidados paliativos pediátricos. Tese (Doutorado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva) - Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/61806>. Acesso em: 14 de jan. 2025.

MANZAN, Letícia Oliveira; FERREIRA, Gabriela Aparecida; RESENDE, Isabella Luiz; SILVA, Júnia Lanny Sousa; BARICHELLO, Elizabeth; FREITAS, Noéle de Oliveira et al. Construção e validação de vídeo educativo sobre cuidados paliativos pediátricos para profissionais de saúde. **Texto Contexto Enferm**. v. 34, p. e20240283, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XdnTC4kZzBmtRnKNWSHmcrd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 14 de jan. 2025.

MARTINS, Matheus Rodrigues; OLIVEIRA, Juliana da Silva; SILVA, Alexandre Ernesto; SILVA, Rudval Souza da; CONSTÂNCIO, Tatiane Oliveira de Souza; VIEIRA, Sheylla Nayara Sales. Assistance to patients eligible for palliative care: the view of professionals from an Intensive Care Unit. **Rev Esc Enferm USP**. v.56, p. e20210429, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/199093>. Acesso em: 14 de jan. 2025.

MENDES, Ana Magnolia. Novas formas de organização do trabalho, ação dos trabalhadores e patologias sociais. In: MENDES, Ana Magnolia (Ed.). **Psicodinâmica do trabalho**: Teoria, método e pesquisas (pp. 49-87). São Paulo, SP: Casa do Psicólogo. 2007.

MIGOTO, Michelle Thais; SAGANSKI, Gabrielle Freitas; PERES, Aneís Louise; FREIRE, Márcia Helena de Souza. Mortalidade em crianças menores de cinco anos: revisão integrativa. **R. Saúde Públ. Paraná.** v. 4, n. 2, p. 140-56, 2021. Disponível em: <http://revista.escoladesaude.pr.gov.br/index.php/rspp/article/view/531>. Acesso em: 15 de jan. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: consensos e controvérsias. **Revista Pesquisa Qualitativa**. São Paulo, v.5, n. 7, p. 01-12, 2017. Disponível em: <https://editora.sepq.org.br/rpq/article/view/82/59>. Acesso em: 23 jan. 2024.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento**: Pesquisa qualitativa em saúde. 14ª Ed. Hucitec Editora, São Paulo, 2014.

NIETO, Melissa Gebrim Ribeiro; SEIDL, Eliane Maria Fleury. Reflexões sobre a consonância entre cuidados paliativos em uti e bioética: uma revisão narrativa. **Brasília Med.** v. 61, p. 1-6, 2023. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/rbm.org.br/pdf/v61a310.pdf>. Acesso em 28 de jan. 2025.

OLIVEIRA, Larissa Aragão de Freitas de. O prazer-sofrimento psíquico no trabalho e a perspectiva de Christophe Dejours. **Psic.** v. 8, n. 11, 360-69, 2019. Disponível em: <https://revistas.cesmac.edu.br/psicologia/article/view/846/785>. Acesso em: 19 de mar. 2025.

OLIVEIRA, Estefânia da Silva; CENTENARO, Alexa Pupiara Flores Coelho; GARCIA, Cledir Tânia França; FLORES, Cíntia Maria Lovato; FRANCO, Gianfábio Pimentel; GLOWACKI, Júlia. Da solidão à cooperação: estratégias de enfrentamento de trabalhadores de enfermagem de terapia intensiva. **Cogitare Enferm.** v. 27, p. e82791, 2022. <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/82791>. Acesso em: 27 jan. 2024.

PIVA, Jefferson Pedro; GARCIA, Pedro Celiny Ramos; LAGO, Patrícia Miranda. Dilemas e dificuldades envolvendo decisões de final de vida e oferta de cuidados paliativos em pediatria. **Rev Bras Ter Intensiva.** v. 23, n. 1, p.78-86. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/FhZCpWJbWgnXFZN76v3tRJk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 27 jan. 2024.

PIZZOL, Eduarda Regina Da; SALBEGO, Cléton; SALCHER, Fernanda Gava; MOLIN, Rossano Sartori Dal. Advance directives in the context of pediatric intensive care nursing. **Rev. Bioét.** v. 32, p. e3637EN, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bioet/a/hSpmvqNqZ5B5dNgQqMz76Hx/?lang=en&format=pdf>. Acesso em: 27 jan. 2024.

POLIT, Denise F; BECK, Cheryl Tatano. **Fundamentos de pesquisa em enfermagem**: avaliação de evidências para a prática da enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

POPA, Maria Valentina; MÎNDRU, Dana Elena; DUMITRACHE, Mihaela Hizan; GURZU, Irina Luciana; ANTON-PĂDURARU, Dana Teodora; ȘTREANGĂ, Violeta et al. Stress Factors for the Paediatric and Adult Palliative Care Multidisciplinary Team and Workplace

Wellbeing Solutions. **Healthcare (Basel)**. v. 12, n 9, p. 868-86, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38727425/>. Acesso em: 27 de jul. 2024.

ROSA, Jhennifer Brendha Oliveira; KOBAYASHI, Karina; PASCHUETTO, Giovana Leite; SANTOS, Marcela Yasmin Ferreira dos; NAZAR, Andressa Costa; GABANI, Flávia Lopes. Cuidados paliativos para crianças não oncológicas: perfil de internações em um Hospital Universitário. **Research, Society and Development**, v. 11, n.13, e343111335405, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35405/29774>. Acesso em: 14 de jan. 2025.

SANTOS, Tatiana Vasconcelos dos; MOREIRA, Martha Cristina Nunes; SEVILHA, Marina. A ética do cuidado e cuidado paliativo pediátrico: um diálogo possível. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 4, p. 1011-1019. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/G3fKQsCmbcsXxyKX4G3kdSN/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 15 de jan. 2026.

SCHÄFER, Lizandra Lopes; SILVA, Gisiane Carvalho. Sentimentos familiares em cuidados paliativos pediátricos oncológico: uma reflexão teórica à luz de Martha Rogers. **REASE**. v, 10, n. 6, p. 1508-20, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14244>. Acesso em: 15 de jan. 2026.

SILVESTRI, Aline Paula Spibida; SANTOS, Edilson Lima dos; BELINI, Gabriela Fagan; PELLIZZARO, André Olivo; MOURA, Tamires da Silva; GONÇALVES, Suelen et al. Equipe de enfermagem frente aos cuidados paliativos em pediatria: Revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, e13910514848, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/14848/13183/191991>. Acesso em: 22 jan. 2024.

SILVA, Alexandre Ernesto; SILVA, Rosimeire de Paula; SILVA, Danyelle Maria; FERREIRA, Hellen Carolina Moraes; MIRANDA, Carolina Eloi; INÁCIO, Jaqueline Layane da Silva, et al. Estratégias utilizadas na prática dos cuidados paliativos em terapia intensiva neopediátrica. **Research, Society and Development**, v. 10, n.10, e506101018277, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18277>. Acesso em: 26 jan. 2024.

SILVA, Giselle de Fátima. **Cuidados paliativos, psicologia e políticas públicas: diálogos e interfaces**. In: POLEJACK, Larissa; VAZ Amanda Maria de Albuquerque, GOMES, Pérolla Melo Goulart; WICHROWSKI, Victor Costa (Org.). *Psicologia e Políticas Públicas na Saúde: Experiências, Reflexões, Interfaces e Desafios*. Série Atenção Básica e Educação na Saúde. Porto Alegre: Rene Unida, 1ª ed. 2015, p. 283-305. Disponível em: <https://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2023/04/Livro-Psicologia-e-Politicass-Publicas-na-Saude-Experiencias-Reflexoes-Interfaces-e-Desafios.pdf>. Acesso em: 05 de mai. 2024.

SILVA, Rosanna Rita; MASSI, Giselle de Athayde. Palliative care services path in Brazil: historical and current aspects. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, p. e222111133545, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/33545>. Acesso em: 14 de mai. 2024.

SNAMAN, Jennifer J; MCCARTHY, Sarah; WIENER, Lori; WOLFE, Joanne. Pediatric Palliative Care in Oncology. **J Clin Oncol.** v. 38, n. 9, p. 954-62, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32023163/>. Acesso em: 27 de jul. 2024.

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Vamos falar de Cuidados Paliativos. São Paulo: SBGG, 2015, 46p. Disponível em: <https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2014/11/vamos-falar-de-cuidados-paliativos-vers--o-online.pdf>. Acesso em: 14 de mai. 2024.

Sociedade Brasileira de Pediatria. Cuidados Paliativos Pediátricos: O que são e qual sua importância? Cuidando da criança em todos os momentos. Departamento Científico de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos (2019-2021). n. 5. 2021. 10p. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23260c-DC_Cuidados_Paliativos_Pediatricos.pdf. Acesso em: 28 de jan. 2025.

TONG, Allison; SAINSBUR, Peter; CRAIG, Jonathan. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. **Int J Qual Health Care.** v. 19, n. 6, p. 349-57, 2007. Disponível em: <https://academic.oup.com/intqhc/article-abstract/19/6/349/1791966?redirectedFrom=fulltext>. Acesso em: 28 de jan. 2025.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2011.

VINCENT, Jean-Louis; MOORE, Frederick A; BELLOMO, Rinaldo; MARINI, John J. **Textbook of Critical Care.** 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2022.

World Health Organization. Palliative care [Internet]. Genebra: WHO; 2017. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/palliative-care>. Acesso em: 23 jan. 2024.

WORLD PALLIATIVE CARE ALLIANCE (WPCA). Global atlas palliative care the end of life. 2 ed. WHO: England, 2020. Disponível em: <https://thewhpca.org/resources/global-atlas-of-palliative-care-2nd-ed-2020/>. Acesso em: 14 de jan. 2025.

ZERNIKOW, Boris. The Silent Epidemic-Chronic Pain and Palliative Care Needs in Children and Adolescents. *Children (Basel)*, v. 11, n. 3, p.283. 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38539318/>. Acesso em: 14 de jan. 2025.

APÊNDICE A – Roteiro de Observação

Descrição do Serviço

- Números de leitos e distribuição;
- Ambiente (privacidade, ruídos, iluminação);
- Adequação para o trabalho desenvolvido (acessibilidade, espaço, decoração);

Assistência

- Como ocorre o planejamento dos cuidados paliativos (conversa com a equipe, conversa com a família);
- Profissional (is) que realizam (aram) o cuidado próximo a criança em cuidados paliativos e suas formações;
- Como são as relações de trabalho (chefia, trabalhadores, crianças e familiares), movimentos de diálogo, negociação, enfrentamento.
- Como é realizado o plano assistencial de cada criança em cuidados paliativos;
- Como ocorre a participação da família em relação ao plano assistencial do seu filho;
- Como é a interface do profissional com a criança em contexto de cuidados paliativos e sua família;
- Como é a passagem de plantão desses casos.

Reuniões

- Há reuniões para discutir casos de crianças em cuidados paliativos (de equipe, com a família)?
- Quem participa dessas reuniões, qual a periodicidade e o tempo de duração?

Trabalhadores

- Qual o envolvimento dos trabalhadores no cuidado à criança em cuidados paliativos;
- Os profissionais possuem afinidade com o que fazem? Há dificuldades em seu cotidiano de trabalho?
- Como é o movimento dentro da equipe (entre os trabalhadores), como ocorre a comunicação e a negociação entre os membros da equipe multidisciplinar;
- Há presença de estresse e insegurança ao cuidar de crianças em cuidados paliativos;
- Há motivação e capacidade de superar obstáculos dos profissionais individualmente e da equipe;
- Quais as características do vínculo de cada profissional, e da equipe como um todo, com as crianças e famílias em cuidados paliativos?

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista**1. Identificação**

Código: _____

Idade: _____

Sexo: () Feminino () Masculino

Já é pai/mãe: () Sim () Não

Profissão: _____

Tempo de formação: _____

Especialização: Sim () Não ()

Qual? _____

Tempo de trabalho no HCPA: _____

Tempo de trabalho na UTIP: _____

2. Roteiro da entrevista semiestruturada

- (1) Fale sobre o seu trabalho no contexto do cuidado de crianças em cuidados paliativos.
- (2) Fale sobre fatores de prazer ao prestar esse cuidado.
- (3) Fale sobre fatores de sofrimento ao prestar esse cuidado.
- (4) Você utiliza alguma estratégia para sofrer menos ao cuidar de uma criança em cuidados paliativos na UTIP? E fora dela?
- (5) Tem alguma questão que você gostaria de acrescentar?
- (6) Você gostaria de ouvir a sua entrevista/suas respostas?

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nº do projeto na Dipe ou CAAE: 89877125.9.0000.5327

Título do Projeto: PRAZER, SOFRIMENTO E ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS DOS TRABALHADORES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NOS CUIDADOS PALIATIVOS NO CENÁRIO DA TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Nome do Pesquisador Responsável	Contato do Pesquisador Responsável
Maria de Lourdes Custódio Duarte	E-mail: malulcd@yahoo.com.br Telefone: (51) 99265-0696
Comitê de Ética	Contato do CEP-HCPA
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CEP-HCPA)	E-mail: cep@hcpa.edu.br, Telefone (51) 33596246 Endereço: Av. Protásio Alves, 211 – Portão 4 - 5º andar do Bloco C -sala 5068, Rio Branco, Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é Analisar os fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar nos cuidados paliativos no cenário da unidade de terapia intensiva pediátrica. Esta pesquisa está sendo realizada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você aceitar o convite, sua participação na pesquisa envolverá informar alguns dados sobre o seu perfil (como idade, sexo, tempo de formação e atuação profissional) e perguntas abertas sobre fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas nos cuidados paliativos no cenário da unidade de terapia intensiva pediátrica à luz da Psicodinâmica do Trabalho (PDT), por meio de uma entrevista individual e você poderá recusar-se a responder qualquer pergunta. As respostas serão gravadas a partir do seu consentimento e, posteriormente, transcritas pela pesquisadora; as transcrições das entrevistas ficarão guardadas por cinco anos e após esse período, serão destruídas. Vale ressaltar que a entrevista será realizada conforme a sua disponibilidade e o tempo previsto para a realização será estimado em uma média de 30 minutos, podendo se estender, se assim for necessário.

Não são conhecidos riscos pela participação na pesquisa, porém poderão surgir desconfortos associado ao tempo de resposta ao questionário, ou pelo conteúdo das perguntas ao falar sobre a sua atividade profissional (e possibilidade de fatores que geram sofrimento no ambiente laboral).

Sua participação na pesquisa não trará benefícios diretos aos participantes, porém, os resultados obtidos poderão contribuir para o aumento do conhecimento sobre o assunto estudado, e, se aplicável, poderá beneficiar futuros participantes, contribuindo com estratégias individuais e coletivas que qualifiquem os processos de trabalho, sobretudo os geradores de sofrimento. Após o término do estudo, será realizado um momento para a apresentação e devolução dos resultados da pesquisa aos participantes.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não

haverá nenhum prejuízo ao vínculo institucional que você recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável ou com o CEP-HCPA.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura

Local: _____

Data: / /

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local: _____

Data: / /

ANEXO B – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE - HCPA



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PRAZER, SOFRIMENTO E ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS DOS TRABALHADORES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DIANTE DA CRIANÇA EM CUIDADOS PALIATIVOS NA TERAPIA INTENSIVA

Pesquisador: Maria de Lourdes Custódio Duarte

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 89877125.9.0000.5327

Instituição Proponente: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.726.407

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo do projeto e das Informações Básicas da Pesquisa PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_ 2562940, de 11/07/2025.

Analisar os fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar no cuidado à criança em cuidados paliativos em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, que será realizada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), hospital universitário de referência na região de Porto Alegre, que presta assistência de atenção terciária. Serão convidados a participar do estudo 29 trabalhadores da equipe multidisciplinar, ou seja, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, técnicos de enfermagem, nutricionistas e assistentes sociais, que atendam os critérios de seleção para o estudo. A fim de alcançar os objetivos propostos e produzir as informações, escolheu-se a técnica de entrevista semiestruturada e a observação participante. Estas serão analisadas de acordo com a Análise Temática, proposta por Minayo (2014), compreendida em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, com o auxílio do software NVivo, para auxiliar na organização e codificação dos dados. O

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.410-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.726.407

estudo será apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente, via Plataforma Brasil, e respeitará as normas éticas do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Possíveis contribuições do estudo: Os resultados serão utilizados para fins científicos e ajudarão a conhecer as especificidades diante dos sentimentos de prazer, sofrimento e estratégias defensivas verbalizados pelos trabalhadores da equipe multidisciplinar no cenário da terapia intensiva, que prestam cuidado às crianças em cuidados paliativos, à luz da Psicodinâmica do Trabalho. O estudo pode contribuir, ainda, para a discussão sobre questões relacionadas à saúde dos trabalhadores dos locais estudados, na medida em que dá visibilidade ao sofrimento destes, contribuindo para o desencadeamento de um processo de reflexão sobre o tema.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Analisar os fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar no cuidado à criança em cuidados paliativos em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.

Objetivo Secundário:

- Caracterizar os trabalhadores da equipe multidisciplinar no cenário da UTI Pediátrica;-
- Identificar os fatores de prazer dos trabalhadores da equipe multidisciplinar decorrentes do cuidado paliativo prestado em UTI Pediátrica;
- Identificar os fatores de sofrimento dos trabalhadores da equipe multidisciplinar decorrentes do cuidado paliativo prestado em UTI Pediátrica;
- Conhecer as estratégias defensivas individuais e coletivas dos trabalhadores da equipe multidisciplinar diante do cuidado paliativo no contexto da UTI Pediátrica.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Os riscos relacionados à participação são referentes ao possível desconforto ou constrangimento ao abordar o conteúdo das perguntas, por ser um relacionado ao (possível fator de sofrimento) ambiente laboral.

A relação risco/benefício do projeto submetido é aceitável e adequada.

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.726.407

Benefícios:

Não existem benefícios diretos aos participantes, porém, os resultados poderão contribuir para o aumento do conhecimento sobre o assunto estudado, e, se aplicável, poderá beneficiar futuros participantes, contribuindo com estratégias individuais e coletivas que qualifiquem os processos de trabalho, sobretudo os geradores de sofrimento.

A relação risco/benefícios está adequada.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva e tem como referencial teórico a Psicodinâmica do Trabalho, proposta por Christophe Dejours. Além disso, esta pesquisa utiliza o instrumento Consolidated Criteria for REporting Qualitative research (COREQ), a fim de fortalecer o rigor metodológico. Esta ferramenta contempla 32 critérios em três domínios: equipe de pesquisa e reflexividade, conceito do estudo, análise e resultados que permitem a qualificação do estudo (Tong; Sainsbur; Craig, 2007).

O estudo será realizado nas Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), que faz parte do Serviço de Enfermagem Pediátrica (SEPED) do HCPA. A UTIP possui aproximadamente o seguinte quantitativo de profissionais ativos: 23 enfermeiros, nove fisioterapeutas, 66 técnicos de enfermagem, 23 médicos, uma nutricionista, uma assistente social, uma psicóloga. Além disso, também transitam na UTIP, os residentes do Programa de Residência Médica, sendo de ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva Pediátrica, e do Programa de Residência Multiprofissional à Saúde, mais especificamente de Atenção à Saúde da Criança. Entende-se que residentes do 2º ano também poderiam agregar nas informações da pesquisa, pois há um grande amadurecimento a nível profissional devido à carga horária elevada de imersão nas atividades assistenciais. Serão convidados a participar do estudo cinco trabalhadores de cada categoria profissional da equipe multidisciplinar que atendam os critérios de seleção para o estudo, exceto as profissões: nutrição, psicologia e serviço social, onde serão convidados apenas três de cada categoria, pois se trata de apenas um profissional contratado e dois residentes do segundo ano. Optou-se pela escolha desses profissionais devido à proximidade no cuidado às crianças em cuidados paliativos no contexto da UTIP. Sendo assim, espera-se uma totalidade de, pelo menos, 29 participantes.

A coleta das informações do presente estudo será realizada por meio de entrevista semiestruturada (Apêndice B), contendo questões fechadas sobre o perfil dos profissionais e

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.726.407

questões abertas sobre os fatores de prazer, sofrimento e estratégias defensivas individuais e coletivas diante do cuidado a criança em cuidados paliativos na UTIP. Está previsto um teste piloto a fim de verificar se as questões estão adequadas para compreensão do profissional entrevistado.

Será realizado um primeiro contato com os profissionais da equipe multiprofissional de forma presencial, onde será feito o convite para participação. Confirmado o interesse do participante, será agendado um dia da preferência do entrevistado, fora de sua jornada de trabalho, para a realização da entrevista de forma presencial e em local reservado e sem ruídos, na própria unidade ou em sala disponibilizada pelo Centro de Pesquisa Clínica (CPC) do HCPA.

A coleta das informações terá o período previsto de julho a outubro de 2025 para serem realizadas e o tempo aproximado para a aplicação da entrevista será estimado em uma média de 30 minutos, podendo se estender, se assim for necessário. As entrevistas serão aplicadas pela pesquisadora do estudo, atualmente mestranda, com auxílio de uma bolsista de iniciação científica, ambas com experiência em coleta de dados de pesquisa qualitativa, e que não possuem relação interpessoal prévia com a equipe do estudo. As interações irão iniciar após a apresentação do projeto à chefia da unidade, e com a observação participante juntos aos trabalhadores em campo assistencial.

A entrevistas serão audio gravadas e transcritas na íntegra de forma literal, sendo codificadas pela letra conforme categoria profissional, seguida pelo número e código de acordo com a sequência em que ocorrerão. As informações serão analisadas de acordo com a Análise Temática, proposta por Minayo (2014), com três etapas designadas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

O projeto possui TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e está adequado as normas pré estabelecidas.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

As pendências emitidas para o projeto no parecer N.º 7.688.957 foram respondidas pelos pesquisadores, conforme carta de respostas adicionada em 11/07/2025 e conforme colado abaixo. **NÃO APRESENTA NOVAS PENDÊNCIAS.**

Endereço: Av. Protásio Alves, n.º 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.726.407

PENDÊNCIA ANTERIOR Nº 01 - O TCLE apresentado deverá ser revisado, para atender às normas vigentes. Um modelo de TCLE pode ser consultado na página do HCPA> Pesquisa> Área do Pesquisador> Projetos com seres humanos> Modelos de Documentos.

<https://sites.google.com/hcpa.edu.br/area-dopesquisador/projetos/projetos-seres-humanose-outros/modelos-de-documentos-sereshumanos#h.84dywhame11f>

- Atualizar o endereço do CEP no TCLE/TALE para: Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h, telefone (51) 33596246, e-mail cep@hcpa.edu.br.

- Incluir risco de quebra de privacidade no TCLE, bem como PB.

RESPOSTA PESQUISADORES:

Prezados, agradecemos as contribuições! O projeto foi revisado conforme as pendências solicitadas:

- O TCLE foi revisado e anexado em conformidade ao modelo disponível no link indicado pelos revisores. O título do TCLE está demarcado em amarelo no documento principal do projeto de pesquisa, além de ser anexado individualmente também na Plataforma Brasil.

- O endereço atualizado também foi adicionado ao novo TCLE, bem como o risco de quebra de privacidade.

PENDÊNCIA ATENDIDA.

Considerações Finais a critério do CEP:

- Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS N.º 466/2012 e na Norma Operacional CNS/Conep N.º 001/2013, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.

- O projeto está aprovado para inclusão ou revisão de registros de 29 participantes no HCPA.

- Os projetos executados no HCPA somente poderão ser iniciados quando seu status no sistema AGHUse Pesquisa for alterado para „Aprovado“, configurando a aprovação final da Diretoria de Pesquisa.

- Textos e anúncios para divulgação do estudo e recrutamento de participantes deverão ser submetidos para apreciação do CEP, por meio de Notificação, previamente ao seu uso. A

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
 Bairro: Rio Branco CEP: 90.410-000
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE
 Telefone: (51)3359-6246 Fax: (51)3359-6246 E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.726.407

redação deverá atender às recomendações institucionais, que podem ser consultadas na Página da Pesquisa do HCPA, Área do Pesquisador / Execução e Acompanhamento dos Projetos / Recrutamento - Divulgação. Link: <https://sites.google.com/hcpa.edu.br/area-do-pesquisador/projetos/projetos-seres-humanos-e-outros/execu%C3%A7%C3%A3o-e-acompanhamento-de-projetos-cep#h.w98illx4hhgw>

- Eventos adversos deverão ser comunicados de acordo com as orientações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep (Carta Circular N.º 13/2020-CONEP/SECNS/MS). Os desvios de protocolo também deverão ser comunicados em relatórios consolidados, por meio de Notificação.

- Deverão ser apresentados relatórios anuais e um relatório final. Estes relatórios deverão ser submetidos acompanhados do Relatório Consolidado de Eventos Adversos Graves (EAGs), conforme preconiza a Carta Circular nº 13/2020-CONEP/SECNS/MS.

- Os modelos disponíveis para Notificação de Eventos Adversos e Relatórios Consolidados de EAGs podem ser consultados na Página da Pesquisa do HCPA, Área do Pesquisador / Execução e Acompanhamento dos Projetos / Eventos adversos e desvios de protocolo. Link: <https://sites.google.com/hcpa.edu.br/area-do-pesquisador/projetos/projetos-seres-humanos-e-outros/execu%C3%A7%C3%A3o-e-acompanhamento-de-projetos-cep#h.w98illx4hhgw>

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2562940.pdf	11/07/2025 21:05:54		Aceito
Outros	Carta_resposta.pdf	11/07/2025 21:05:44	Maria de Lourdes Custódio Duarte	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	11/07/2025 21:05:31	Maria de Lourdes Custódio Duarte	Aceito

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.726.407

Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_CEP11_07.pdf	11/07/2025 21:05:23	Maria de Lourdes Custódio Duarte	Aceito
Orçamento	ORCAMENTO.pdf	22/05/2025 20:15:33	Maria de Lourdes Custódio Duarte	Aceito
Cronograma	CRONOGRAMA.pdf	22/05/2025 20:14:14	Maria de Lourdes Custódio Duarte	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_Rosto.pdf	22/05/2025 20:12:13	Maria de Lourdes Custódio Duarte	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 25 de Julho de 2025

Assinado por:
Daisy Crispim Moreira
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br